

儿科针灸疗法

任守中

人民卫生出版社

1958

研习中医

发扬国粹

目 錄

第一章 小儿針灸療法

的特点 1

第二章 針法 2

一、針的种类 2

二、針的結構 2

三、針刺的方向 3

四、針刺的深淺 3

五、針刺前的准备 3

六、針法的操作 4

七、暈針、滯針、弯針、折針的处理 5

八、指針療法 8

九、禁刺 8

第三章 灸法 9

一、艾卷灸法 9

二、艾炷灸法 9

三、溫灸器灸法 10

四、禁灸 11

五、灸治时的注意事項 11

第四章 孔穴总論 11

一、孔穴、經穴与經外奇穴 11

二、測定穴位的方法 12

三、針灸治疗儿科病症常用穴位 13

(一) 手太阴肺經穴 13

1. 尺澤 2. 列缺 3. 少商

(二) 手阳明大腸經穴 14

1. 商陽 2. 合谷 3. 手

三里 4. 曲池 5. 肘

髁 6. 臂臑 7. 肩髃

8. 禾髃 9. 迎香

(三) 足阳明胃經穴 16

1. 四白 2. 地倉 3. 頰

車 4. 下关 5. 头維

6. 梁門 7. 天樞 8. 伏

兔 9. 阴市 10. 梁丘

11. 足三里 12. 上巨

虛 13. 下巨虛 14. 解

谿 15. 内庭 16. 厉兌

(四) 足太阴脾經穴 20

1. 隱白 2. 商丘 3. 三

阴交 4. 阴陵泉 5. 血

海 6. 箕門 7. 大横

(五) 手少阴心經穴 21

1. 少海 2. 灵道 3. 通

里 4. 神門 5. 少冲

(六) 手太阳小腸經穴 22

1. 少澤 2. 肩貞 3. 听宮

(七) 足太阳膀胱經穴 23

1. 睛明 2. 攢竹 3. 天

柱 4. 大杼 5. 風門

6. 肺俞 7. 脾俞 8. 胃

俞 9. 三焦俞 10. 腎

俞 11. 气海俞 12. 大
陽俞 13. 关元俞
14. 上髎 15. 次髎
16. 中髎 17. 下髎
18. 承扶 19. 股門
20. 委中 21. 承山
22. 崑崙 23. 申脉
24. 至阴

(八) 足少阴腎經穴 28

1. 涌泉 2. 太谿 3. 复
溜 4. 交信 5. 幽門

(九) 手厥阴心包絡經
穴 28

1. 曲澤 2. 間使 3. 内
关 4. 中冲

(十) 手少阳三焦經穴 29

1. 关冲 2. 外关 3. 支
溝 4. 肩髃 5. 翳風
6. 耳門 7. 絲竹空

(十一) 足少阳胆經穴 31

1. 瞳子髎 2. 听会 3. 阳
白 4. 风池 5. 肩井
6. 环跳 7. 风市 8. 中
渎 9. 阳陵泉 10. 光
明 11. 阳輔 12. 悬
鐘 13. 丘墟 14. 脚阴

(十二) 足厥阴肝經穴 34

1. 大敦 2. 行间 3. 太
冲 4. 中封

(十三) 督脉經穴 35

1. 阳关 2. 命門 3. 中
樞 4. 身柱 5. 陶道

6. 大椎 7. 瘡門 8. 风
府 9. 百会 10. 上星
11. 神庭 12. 人中

(十四) 任脉經穴 37

1. 中极 2. 关元 3. 气
海 4. 神阙 5. 下脘
6. 中脘 7. 上脘 8. 巨
阙 9. 天突 10. 承漿

(十五) 經外奇穴 39

1. 太阳 2. 印堂 3. 椎
頂 4. 椎旁 5. 稚間
6. 下极之俞 7. 四縫
8. 十宣

第五章 治疗总論 46

- 一、針灸疗法在小儿科的
适应症与禁忌症 46
- 二、針灸治疗的基本法則 46

第六章 治疗各論 48

- 一、小儿麻疹症 48
- 二、顔面神經麻痺 63
- 三、小儿夜惊症 66
- 四、小儿惊厥 67
- 五、休克 72
- 六、小儿失語症 73
- 七、小儿脑炎后遺症 75
- 八、小舞蹈症 77
- 九、小儿风湿性关节炎 79
- 十、急、慢性胃炎及胃、十
二指腸潰瘍 80
- 十一、小儿幽門痙攣 82

十二、小儿单纯性消化不良·····	85
十三、小儿肠绞痛·····	89
十四、小儿便秘·····	91
十五、小儿夜间遗尿症·····	93
十六、膀胱肌痉挛·····	94
十七、小儿尿潴留·····	96
十八、支气管喘息·····	97

十九、急性扁桃腺炎·····	99
----------------	----

二十、腰椎麻醉后头痛·····	100
-----------------	-----

第七章 通过针灸治疗 儿科病症的实 践对针灸治病 原理的认识与 体会·····	102
---	-----

人命至重

有貴天地

第一章 小儿針灸療法的特点

一、小儿針灸療法与一般的針灸療法具有同样的特点，例如：

(一) 針灸的治疗范围很广，而且确有疗效。

(二) 針灸治疗只需用針、艾絨以及酒精等都很便宜，而不需其他藥物，故能达到节约的目的。

(三) 針灸治疗所需用的器材如針、艾卷、酒精、棉花签等，都很容易携带，故很便利。

(四) 只要应用正确的方法施行針灸，也是相当安全的。

二、施行小儿針灸較大人困难。中医研究院魯之俊院长在其所著新編針灸学內明确指出了：“針灸对小儿較大人困难”。作者在应用針灸治疗的实践中，也深刻体会到这一点。尤其是針治嬰、幼兒更为困难；但这种困难是可以克服的，茲分述如下：

(一) 施行小儿針灸治疗时，很多小儿乱动，不与施术者合作，克服的方法是：对儿童溫和的解釋針治时所用的針是很細的并不疼痛，灸治时会感到一种有溫热舒适的感觉并不痛苦。最有效的方法是让患儿看一看針灸时合作的小儿，爭取引导患儿合作；对不合作患儿宜請护理人员或助手协助固定患儿以免乱动。

(二) 为嬰、幼兒施行針灸治疗时，患儿不象大人能訴說針刺与灸治时的感觉，因此必須掌握針治时的“气至”；为嬰、幼兒及不合作儿童灸治时，建議应用回旋灸法。

第二章 針 法

一、針的种类：針治小儿常用的針有三种：

(一) 毫針：針体細；使用时应用捻轉法，为小儿針治时最常用的針，其长度1—1.5寸，針刺面部及头頂部穴位时亦可应用5分的毫針，針刺較大儿童环跳穴时需要应用2寸或更长的針。患儿与施术者合作时宜用較細的30号或31号針，对不合作小儿用28号針較為妥當。

(二) 圓利針：針体較毫針稍粗而堅硬，速刺时宜用5分或1寸长的細圓利針。

(三) 皮肤針：是对于皮肤表面施行淺刺时所用的針，样式很多。作者所設計的一种小儿皮肤針是用七支26号一寸长的不銹鋼針用銀絲将其一端捆在一起作成針柄，七支不銹鋼針排列的方法是中間一支，周圍六支；应用时手持針柄进行淺刺。

为小儿針治时最好用合金或不銹鋼制成的針，針治較大而且合作的儿童亦可应用金或銀制的毫針。

二、針的結構：分为下列四部分：

(一) 針柄：手持的部位。

(二) 針根：緊接針柄的部位。

(三) 針体：針根与針尖之間。

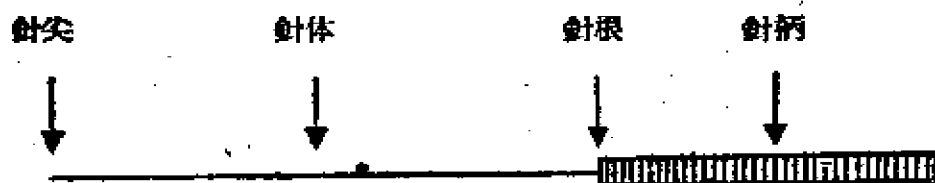


图1 針的各部名称

(四) 針尖：針的尖端。

三、針刺的方向：

(一) 直針：針治時，針與針刺部位的皮膚成直角，叫直針。這是針治時最常用的針刺方向。

(二) 斜針：針治時，針與針刺部位的皮膚成 35 度以上，90 度以下的角度，叫斜針。

(三) 橫針：針治時，針與針刺部位的皮膚成 15 度左右的角，叫橫針。

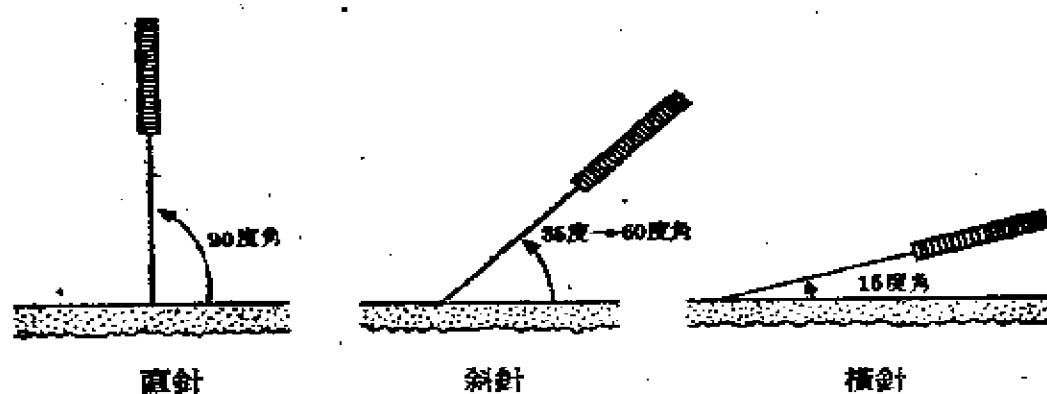


图 2 針刺的方向

四、針刺的深淺：為小兒針治時，針刺的深度較成人為淺，應按照患兒的年齡與胖瘦而不同：年齡愈小，針刺愈淺；年齡較大與身體胖者，針刺較深；身體瘦者，針刺較淺。針刺的深度，除應按照患兒年齡的大小及身體的胖瘦適當增減外，主要取決於針刺的穴位，例如：環跳穴等宜深刺；少商、商陽、中沖等穴宜淺刺。針刺的深淺，亦取決於所採用的針治方法：用皮膚針法連續點刺法或速刺法針治時，一般僅針刺 1、2 分深，遠較應用捻轉法針治時為淺。

五、針刺前的準備：

(一) 根據採用的針治方法及部位，選擇出適當的針，用

捻轉法時，宜用毫針，並根據針刺的部位與深淺，選擇出適當長度的針；針刺頭頂或面部等處穴位時宜選擇5分至1寸長的短針，針刺四肢穴位時宜用1寸至1寸5分長的針，針刺小兒環跳穴時宜用1寸5分至2寸長甚至更長的針。用速刺法或施行連續點刺法時，宜用細圓利針。施行於較大皮膚面淺刺時，宜用皮膚針。

(二) 檢查擬使用的針是否已有損傷，若針已有損傷即不可再用，以免折針。

(三) 用70%或75%的酒精浸針半小時，浸針時宜注意必須將針根、針體與針尖全部浸於酒精內。

(四) 為小兒針治時，最好採取仰臥位、俯臥位或側臥位。若小兒較大而且合作亦可採取坐位。

(五) 對初診患兒或其家長宜進行適當的解釋，解除患兒及其家長不必要的顧慮與恐懼，盡力爭取患兒的合作。

六、針法的操作：

(一) 根據患兒病情與診斷，擬定針刺的穴位，最好用拇指甲在皮膚上壓出十字形的記號。

(二) 一般的穴位消毒可用70%或75%的酒精在擬定的穴位進行消毒。若針刺腹部穴位，頭頂部穴位，項部的風府與瘰癧，脊椎棘突間的穴位（例如：督脈上的大椎、陶道、身柱、命門及陽關等穴位）及臀部的環跳穴時，宜用2.5%碘酒再用70%或75%的酒精消毒。

(三) 針治小兒的方法有四種：

1. 捻轉法：分為用押手捻轉法及不用押手捻轉法兩種。捻轉法是用毫針治病的方法。操作時，用一手的拇指與食指持針柄，然後捻轉進針。進針後，施行捻轉進針，捻轉退針，左右捻動，提插及留針等手法，給予適當的刺激後，捻轉退針。

上下搗動的手法在小兒很少應用。針治小兒，一般不用留針；年齡較大而能合作兒童在必要時亦可留針。捻轉進針後，患兒訴說感到痠、麻、脹等感覺時，宜進行左右捻轉或提插等手法，給予適當的刺激後，捻轉退針。為嬰、幼兒及不合作兒童針治時，宜於發生刺針的感應時，也就是說當施術者感到“氣至”時，應用捻轉提插等手法，給予適當的刺激。當“氣至”的時候，會感到針下沉緊，一種好像魚吞鈎餌的感覺，也就是標幽賦上所說的：“氣之至也，如魚吞鈎餌之沉浮……”捻轉時，可用另外一隻手固定患兒針刺部位，亦即所謂不用押手捻轉法。捻轉時，也可用另一隻手的食指與中指平押在針的兩旁，即所謂用押手捻轉法。採用押手捻轉法時，最好不要用食指與中指緊緊地夾住針體，避免押手與針體或針尖接觸，以免污染針體或針尖。施術時宜聚精會神，遵行古人的遺教：“持針者，手如搏虎，勢若擒龍，心無外慕，如待貴賓。”

2. 速刺法：應用圓利針治療的方法。操作時，用拇指、食指和中指持針，迅速刺入1—2分深，即行出針。

3. 皮膚針法：應用皮膚針對於皮膚一定部位施行淺刺的方法。用一隻手的拇指、食指與中指持皮膚針的針柄進行淺刺，操作時持皮膚針的手由腕部活動一起一落，好像鳥兒啄食一般。

4. 連續點刺法：應用1寸或5分長的細圓利針，在針刺部位上連續點刺數下，好像鳥兒啄食似的，給予淺刺。

（四）捻轉法或速刺法針刺後，宜用消毒的干棉簽或干棉球輕揉針孔，促使針孔閉合。若用皮膚針或連續點刺法時，因針刺很淺，針後不必用干棉簽或棉球揉針孔。

七、暈針、滯針、彎針、折針的處理：

（一）暈針：針治時偶然遇到的一種暈厥現象。症狀：

面色蒼白、出冷汗、頭暈、眼花、四肢厥冷、惡心，甚至暈倒。暈針較易發生于初次針治的病人，因懼怕針刺，或神經過敏，體位不合适所致。身體過于衰弱，飢餓或疲勞過度時也容易發生暈針。根據小兒針治已往臨床的經驗，未曾遇到過嬰、幼兒暈針現象，可能是為嬰、幼兒針治時多系採用臥位的原故。較大兒童可能比較容易發生暈針，因為較大兒童比較懂事，可能因懼怕針刺，神經過度緊張，神經過敏而發生暈針，故宜特別注意，提高警惕，作好預防暈針的工作。預防暈針的方法是：

1. 針治小兒時，最好採取臥位，尤其是对初次來針治的患兒，以及身體衰弱，神經過敏，懼怕針刺的病人，均宜採取臥位。對於飢餓的病人最好不針，若不能進食而必需針治時，亦必需採取臥位，而且宜採用比較弱的刺激。對於過于疲勞的病人，宜休息片刻後再行針刺，並宜採取臥位。

2. 對於初次針治及懼怕針刺，精神緊張，神經過敏的兒童，應做好解釋工作。向他解釋針灸療法是相当安全的療法，針刺時不疼，只是感覺有點痠麻，並不难受，解除患者不必要的顧慮與懼怕。

3. 針治時，應當避免強烈的刺激。倘若發生暈針時，應當及時處理，處理的方法是：(1)使病人平臥床上，去掉枕頭，使頭部放低。(2)針刺人中、少商、中沖等穴位急救。

(二) 滯針：針治時，遇到捻轉不動，進退不能的情形，即為滯針，可能因局部肌肉痙攣所致。遇此情形，不可驚惶失措。處理的方法是：

1. 留針不動，待局部肌肉鬆弛後再捻轉退針。
2. 用手指在滯針附近循按，使肌肉鬆弛，即可將針退出。
3. 若仍退不出針，也可以在滯針附近的其他穴位再刺一

針，常會解除滯針的困難。

4. 用艾卷灸針刺部位及其周圍。

(三) 彎針：入針後，有時會發生針在人體內變成彎曲的情形，名為彎針。由於患兒的亂動，可能發生彎針，故應時刻提高警惕，預防彎針的發生。預防的方法是：首先爭取患兒的合作，囑患兒於針治時不要亂動。必要時，宜請護理人員或助手協助固定患兒的體位。針治時，宜避免給予突然過強的刺激，以免引起局部肌肉急劇的收縮而引起彎針。針治前宜找準穴位，針治時宜避免針尖觸到堅硬的組織，以免引起彎針。針刺小兒恰在兩骨之間的穴位時，例如針刺恰在脛骨與腓骨之間的足三里穴時，由於患兒下肢突然亂動可能發生針體被脛骨與腓骨夾住的情況。此時持針的手應立即放鬆，以免發生彎針甚至折針。針在體內變成彎曲時，應當順着彎曲的方向，輕輕捻動，向針柄傾斜的方向將針順勢緩緩退出，切不可用力捻轉提插，以免更難將針退出，甚至發生折針。

(四) 折針：如針的質量欠佳或針體已有損傷而依然使用，均有可能發生針在體內折斷的情形。針治時，如果突然給予過強的刺激，即可能引起肌肉突然發生強烈的痙攣而引起折針。針刺時，患兒突然肢體亂動亦可能發生折針。萬一針折斷在體內時，施術者務宜鎮靜，如果針體外露，可用鑷子、鉗子或手將針拔出；如果折斷部分全在皮下，應當即刻設法將針向外托出；如果斷在體內的針離骨骼很近，可利用骨骼將針頂出。如不能取出，折針亦不在重要臟器附近，大都不致發生危險，因為時間久了，斷針部分在體內即被氧化或被結締組織包圍，而不致發生危害。如折針近于重要臟器時，應及時請外科醫師處理。折針在體內雖然很少發生危害，但亦應盡力防止，尤其是為不合作小兒針治時，更應當特別加以警惕。預防折

針，应注意以下几点：

1. 針的選擇：一定要用合金或不銹鋼等制成的質量好而且富有彈性的針。

2. 針治前的準備：应当檢查所要用的針，若針體有損傷即不可用。或發生過硬彎，即不可再用。

3. 針治時，不要施行突然的強刺激。

4. 針治時，不應將針體全部刺入體內，要將針體之一部留在皮外。

八、指針療法：指針療法是以手指代針治療疾病的方法，操作時用指尖按壓、揉按或掐的手法在穴位上施以適當的刺激。這種療法易于學習，并且适用于小兒，值得推廣應用。指針療法對於某些病症確有療效。例如：休克、暈厥及虛脫的患者急救時，可用拇指、食指或中指掐人中穴。咽喉痛、咳嗽，可用食指抵魚際拇指掐合谷穴。頭痛，可以用指尖按壓、揉按或掐太陽、頭維等穴。牙痛可用指尖按壓、揉按或掐頰車、下關等穴。

九、禁刺：有些穴位是不能針刺的，例如：腹部的神闕穴，因為臍窩難以消毒，針刺後易感染。前囟門尚未閉合的嬰、幼兒頭頂部的額會穴是禁止針刺的。

有些穴位是禁止深刺的，例如：項部的風府穴的深部為延髓所在，不宜深刺；瘻門穴的深部有脊髓，亦不宜深刺。肩井穴亦不可深刺，因深刺恐傷及鎖骨下動脈。此外，背部的椎旁，大杼、風門及肺俞等穴亦不可深刺。

凡需用外科手術或其他方法才能治好的病症，都應視為針治的禁忌症，例如：急性腹膜炎、腸套迭、氣管異物、骨折等。

第三章 灸 法

灸治是用艾絨等燃着后，以其所产生的溫熱刺激人体上的穴位防治疾病的方法。灸治的方法有艾卷灸法，艾炷灸法及溫灸器灸治法。

一、艾卷灸法：艾卷灸法是用紙將艾絨卷成艾卷，用一手的拇指、食指与中指持着艾卷的一端，將艾卷的另外一端燃着，靠近灸治穴位的皮肤，給以溫熱的刺激。这种灸法是中医研究院針灸研究所朱璉所长倡用的，这种灸法既方便而且效果良好，值得广泛应用。

朱璉同志在新針灸学(1954年10月新1版)中介绍的艾卷灸操作法有两种：

(一) 溫和灸法：手持艾卷的一端，將燃着的艾卷，靠近欲灸治穴位，連續地給予病人溫和舒适的刺激。

(二) 雀啄灸法：將燃着的艾卷对准皮肤上应灸治的穴位，一起一落，象麻雀啄食般給以斷續的溫熱刺激。

以上两种灸法均适用于年龄較大而且与施术者很合作的儿童。年龄較小及不合作的儿童用以上两种灸法，均感困难。因此，作者在溫和灸法的基础上研究出回旋灸法：將艾卷燃着的一端距灸治取穴皮肤約1.5—2厘米高处緩慢地做小回旋动作，向左或向右回旋均可。这种回旋灸法对嬰幼兒童都很适合，是艾卷灸法中的一种新而且实用的操作方法。

应用艾卷灸法为小儿灸治时，每个穴位可以灸2—5分钟或灸至局部发紅为度。

二、艾炷灸法：艾炷灸法是将艾絨捏成圓椎状的艾炷，放在灸治的穴位上，燃着艾炷的尖端，燃燒到皮肤感觉燙的时

候就拿掉，再換上一個艾炷。每用一個艾炷，叫做灸一壯。艾炷灸法效果良好，但是操作較艾卷灸麻煩，而且必須得到患者的合作，因而年齡較大的患兒才能使用，每次可以灸2—5壯。

艾炷灸法可按艾炷下面是否隔以其他物質，分為著膚灸，隔薑灸，隔蒜灸與隔鹽灸：

（一）著膚灸：灸治時，將艾炷直接放在灸治穴位的皮膚上。

（二）隔薑灸：灸治時，將薄薑片墊在艾炷下面。

（三）隔蒜灸：灸治時，將薄蒜片墊在艾炷下面。

（四）隔鹽灸：灸臍時，放鹽粒于臍窩內，上置艾炷灸之。

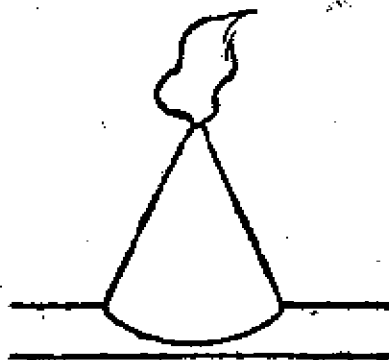


圖3 艾炷灸法

三、溫灸器灸法：溫灸器灸治法是用一種容器，內燃艾絨以所發生的溫熱治療疾病的方法。灸腹部，腰部或背部時比較適用，每次可以灸2—5分鐘。這種灸法不適用於嬰、幼兒及年齡較小的兒童。年齡較大的兒童可以應用。

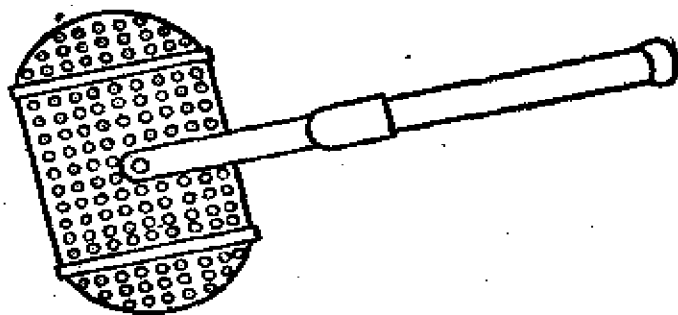


圖4 溫灸器灸治法

四、禁灸：人体上有些穴位是禁灸的，例如：攒竹、睛明、絲竹空等眼睛周圍的穴位是禁灸的。此外，头維、太阳、迎香、禾髻、风府、痲門等穴也是禁灸的。头顶部的顙会穴在前囱門尚未閉合的小儿，不但禁針，而且禁灸。

五、灸治时的注意事項：

(一) 灸治时，应聚精会神、耐心的操作；預防患儿于灸治时突然乱动；于灸治前解釋灸治并无痛苦，并囑患儿于灸治时不要乱动，必要时，应請人协助固定患儿。

(二) 为嬰、幼兒灸治时，最好用回旋灸法。灸治时，用一手持艾卷；另一手食指与中指分开，平押于灸治穴位的兩旁，以預防患儿突然移动时好給予固定。

(三) 灸治时，宜注意观察患者，因灸治时亦会发生暈厥、出冷汗等症狀，即所謂暈灸。发生暈灸时，应立即处理。处理的方法与暈針同。

(四) 灸完后应将艾卷燃着的一端剪掉，投入帶盖的瓷罐內，以免艾絨复燃，引起火灾。

第四章 孔 穴 总 論

一、孔穴、經穴与經外奇穴

人身上可以針刺或灸治的部位叫做孔穴，又叫做穴位，也就是針灸治疗时所采用的刺激点。这些穴位是数千年来应用針灸治病的实践当中逐漸发现和积累起来的，經驗証明身体上每一个穴位并非对各种病症都同样有效，因此我們在应用針灸治病时，必需根据病症选择适当的穴位，而且需取穴准确給予适当的刺激，才能收到效果。

人身上有十四經脉。所謂經脉，就是全身氣血循行的通路。根據祖國醫學的記載，人體有五臟（心、肝、脾、肺、腎）六腑（大腸、小腸、三焦、胃、胆、膀胱），外加心包，共有十二臟腑，各分別與經脉一條有着非常密切的聯繫，即所謂十二經脉，再加上頭背部正中綫的督脉與胸腹部正中綫的任脉，合稱為十四經脉。

氣血的循行，由手太陰肺經開始，以次經過手陽明大腸經、足陽明胃經、足太陰脾經、手少陰心經、手太陽小腸經、足太陽膀胱經、足少陰腎經、手厥陰心包絡經、手少陽三焦經、足少陽膽經及足厥陰肝經；由足厥陰肝經又回到手太陰肺經，氣血就是這樣地在十二經內周而復始的循環不息。氣血循行一周回到肺經以後，另有一個分枝，氣血由手太陰肺經通過督脉，由督脉循行至任脉，由任脉又回到手太陰肺經。

在十四經脉上的穴位叫做經穴。十四經發揮銅人腧穴針灸圖經均記有穴名 354 個，針灸大成記載經穴名 359 個。十四經以外的孔穴，叫做經外奇穴。

二、測定穴位的方法

（一）中指同身寸法：使患者中指屈曲，各節互呈直角時，第一、二節間橫紋尖與第二、三節間橫紋尖之間的距離，作為 1 寸，叫做中指同身寸，為度量患者四肢的橫寸與直寸的標準單位，也可用作度量患者腰背部橫寸的標準單位。

（二）頭部直寸的折量法：以大椎至眉心（兩眉頭的中央）作為 18 寸，將大椎至眉心的距離折成 18 等分，每 1 等分



圖 5 中指同身寸

叫做1寸，作为头部直行寸的标准单位。

(三) 头部横寸的折量法：以目内眦至目外眦之间宽度，作为1寸，用以测量头部的横寸。亦可将头部两个头维穴之间的距离，作为9寸，折成9等分，每1等分作为1寸，为测量头部横寸的标准单位。

(四) 胸部与腹部横寸的测量法：将两乳头之间的距离作为8寸，分为8等分，每1等分即为1寸，为测量胸腹部横径的标准单位。

(五) 胸部直寸的测量法：自胸骨柄颈切迹上缘中央的天突穴至两乳头连线中点的膻中穴之间的距离，作为8寸，为量胸部直寸的标准。

(六) 腹部直寸的测量法：自剑突至脐作为8寸，作为量上腹部直寸的标准。自脐至耻骨联合上缘的曲骨作为5寸，分为5等分，每1等分作为1寸，为测量下腹部直寸的标准。

(七) 依据明显的解剖标志定穴的方法：身体上有很多明显的解剖标志，可以利用这些标志来定穴位。测定背部及腰部直线上的穴位时，可以根据脊椎棘突来定穴位，例如：大椎穴的定穴法是在第七颈椎棘突之下凹陷处，阳关穴的定穴法是在第四腰椎棘突与第五腰椎棘突之间，又如阳陵泉的定穴法是在腓骨小头的前下方凹陷处。

三、针灸治疗儿科病症常用穴位

人体上可以针灸的穴位很多，仅将针灸治疗儿科病症常用穴位的定穴法、神经分布、针刺深度（以中指同身寸为标准）、灸治时间、及治疗病症分述之。

(一) 手太阴肺经穴：

1. 尺泽

定穴法：肘窩橫紋的橈側端。

神經分布：橈神經及前臂外側皮神經。

針灸療法：針3分深，灸2—3分鐘（有的書中記載禁灸）。

治療病症：小兒麻痺症、支氣管炎、支氣管喘息、小兒驚厥。

2. 列缺

定穴法：在橈骨莖突之上方，腕上1寸5分處。

神經分布：橈神經及前臂外側皮神經。

針灸療法：針1—2分深，灸2—5分鐘。

治療病症：顏面神經麻痺、顏面神經痙攣、頭痛（腰椎麻醉後頭痛等）、牙痛、三叉神經痛、橈神經麻痺。

3. 少商

定穴法：在拇指橈側，距爪甲角1分處。

神經分布：橈神經的淺枝及正中神經分布的指掌側固有神經。

針灸療法：針1分深，不宜灸。針治因患急性扁桃腺炎而發高燒的患兒時，針刺後少量放血更為有效。

治療病症：小兒驚厥（包括癲癇）、休克、暈厥、急性扁桃腺炎、喉頭炎、口腔炎、橫膈膜痙攣。

（二）手陽明大腸經穴：

1. 商陽

定穴法：在食指的橈側，去爪甲角1分處。

神經分布：來自正中神經的指掌側固有神經。

針灸療法：針1分深，不宜灸。

治療病症：小兒驚厥（包括癲癇）、急性扁桃腺炎、喉頭炎、牙痛。

2. 合谷

定穴法：手第一掌骨与第二掌骨之間，靠近第二掌骨邊緣。

神經分布：橈神經。

針灸療法：針3—5分深，灸2—5分鐘。

治療病症：小兒麻痺症、顏面神經麻痺、顏面神經痙攣、小兒驚厥、癲癇、舞蹈病、虛脫、單純性消化不良、幽門痙攣、支氣管喘息、支氣管炎、急性扁桃腺炎、頭痛、牙痛、衄血、耳聾、耳鳴、失語症。

3. 手三里

定穴法：肘橫紋外端曲池穴之下2寸。

神經分布：橈神經及前臂背側皮神經。

針灸療法：針3—5分深，灸2—5分鐘。

治療病症：小兒麻痺症、風濕性肘關節炎、牙痛、口腔炎。

4. 曲池

定穴法：屈肘時，肘橫紋的外端。

神經分布：橈神經及前臂背側皮神經。

針灸療法：針5分深，灸2—5分鐘。

治療病症：小兒麻痺症、舞蹈病、風濕性肘關節炎、急性扁桃腺炎、支氣管炎、支氣管喘息、肋間神經痛。

5. 肘髁

定穴法：曲池穴上1寸。

神經分布：臂背側皮神經。

針灸療法：針3分深，灸2—5分鐘。

治療病症：小兒麻痺症，風濕性肘關節炎。

6. 臂臑

定穴法：肘上7寸，在肱骨的外側，肩髃穴下3寸处。

神經分布：腋神經与臂背側皮神經。

針灸療法：針3分深，灸2—5分钟。

治疗病症：小儿麻痺症、臂神經痛。

7. 肩髃

定穴法：在肩端。

神經分布：臂外側皮神經及后鎖骨上神經。

針灸療法：針5—6分深，灸2—5分钟。

治疗病症：小儿麻痺症、风湿性肩关节炎、臂神經痛。

8. 禾髃

定穴法：人中穴旁5分处，在鼻翼及上唇之間。

神經分布：三叉神經第二枝的眶下神經。

針灸療法：針1—3分深，禁灸。

治疗病症：急性鼻炎、慢性鼻炎、衄血、顏面神經麻痺、顏面神經痙攣。

9. 迎香

定穴法：鼻孔旁，鼻翼外緣。

神經分布：顏面神經及三叉神經第二枝的眶下神經。

針灸療法：針1—2分深，禁灸。

治疗病症：急性鼻炎、嗅觉减退、衄血、喘息、顏面神經麻痺。

(三) 足阳明胃經穴：

1. 四白

定穴法：眼直視时，瞳孔之下方1寸处。

神經分布：顏面神經及三叉神經第二枝的眶下神經。

針灸療法：針1—3分深，灸2—3分钟(灸时病人宜仰卧，閉目)。

治疗病症：顏面神經麻痺、顏面神經痙攣、三叉神經痛、上頷竇炎。

2. 地倉

定穴法：口角外方約4分处。

神經分布：顏面神經及三叉神經第二、三枝。

針灸療法：針3分深，灸2—5分鐘。

治疗病症：顏面神經麻痺、顏面神經痙攣、口裂諸肌痙攣、三叉神經痛。

3. 頰車

定穴法：下頷角前上方一橫指处。

神經分布：顏面神經，三叉神經第三枝及耳大神經。

針灸療法：針3分深，灸2—5分鐘。

治疗病症：顏面神經麻痺、顏面神經痙攣、三叉神經痛、齒神經痛、口腔炎、流涎症、急性扁桃腺炎。

4. 下关

定穴法：耳前，顴骨弓下。

神經分布：顏面神經及三叉神經第三枝。

針灸療法：針3分深，灸2—3分鐘（有的书上記載禁灸）。

治疗病症：顏面神經麻痺、齒神經痛、三叉神經痛。

5. 头維

定穴法：神庭穴(眉間之上3寸)旁开4寸5分处。

神經分布：顏面神經及三叉神經第一、二枝。

針灸療法：針3分深，禁灸。

治疗病症：头痛、偏头痛、顏面神經麻痺。

6. 梁門

定穴法：中脘穴(脐上4寸)旁开2寸。

神經分布：肋間神經。

針灸療法：針3—5分深，灸2—5分鐘。

治療病症：急性胃炎、胃痙攣、食欲減退、消化不良。

7. 天樞

定穴法：臍兩旁2寸處。

神經分布：肋間神經。

針灸療法：針5分深，灸2—5分鐘。

治療病症：單純性消化不良、習慣性便秘。

8. 伏兔

定穴法：膝上6寸，股骨的前外側。

神經分布：股神經。

針灸療法：針5—6分深，灸2—3分鐘。

治療病症：小兒麻痺症、腳氣病。

9. 陰市

定穴法：膝上3寸，股骨的前外側。

神經分布：股神經。

針灸療法：針3—4分深，灸2—3分鐘。

治療病症：小兒麻痺症、腳氣病。

10. 梁丘

定穴法：膝上2寸，股骨的前外側。

神經分布：股神經。

針灸療法：針3—4分深，灸2—5分鐘。

治療病症：小兒麻痺症、風濕性膝關節炎。

11. 足三里

定穴法：在外膝眼之下3寸，脛骨外側。

神經分布：腓深神經及腓腸外側皮神經。

針灸療法：針2—5分深，灸2—3分鐘。

治疗病症：单纯性消化不良、习惯性便秘、急性胃炎、慢性胃炎、胃及十二指肠溃疡、胃痉挛、幽门痉挛、食欲减退、脚气病、小儿麻痹症、风湿性膝关节炎、舞蹈病。

12. 上巨虚

定穴法：足三里穴下3寸，在胫骨与腓骨之间。

神经分布：腓深神经及腓肠外侧皮神经。

针灸疗法：针3—5分深，灸2—5分钟。

治疗病症：小儿麻痹症、脚气病、食欲减退、消化不良。

13. 下巨虚

定穴法：足三里穴下6寸，在胫骨与腓骨之间。

神经分布：腓深神经及腓肠外侧皮神经。

针灸治疗：针3—5分深，灸2—5分钟。

治疗病症：小儿麻痹症、脚气病、食欲减退。

14. 解谿

定穴法：足腕上系鞋带处。

神经分布：腓浅神经。

针灸疗法：针3—5分深，灸2—5分钟。

治疗病症：小儿麻痹症、风湿性踝关节炎、便秘。

15. 内庭

定穴法：二足趾与三足趾之趾缝处。

神经分布：趾背神经。

针灸疗法：针3分深，灸2—5分钟。

治疗病症：衄血、牙痛。

16. 厉兑

定穴法：足第二趾外侧，趾甲旁1分处。

神经分布：趾背神经。

针灸疗法：针1分深，灸2—3分钟。

治疗病症：急性扁桃腺炎、消化不良。

(四) 足太阴脾经穴：

1. 隐白

定穴法：足大指内侧，趾甲旁1分处。

神经分布：趾背神经。

针灸疗法：针1分深，灸2—3分钟。

治疗病症：小儿惊厥、晕厥。

2. 商丘

定穴法：内踝前下方凹陷处。

神经分布：足背内侧皮神经(来自腓浅神经)及小腿内侧皮神经。

针灸疗法：针3分深，灸2—5分钟。

治疗病症：小儿麻痹症。

3. 三阴交

定穴法：内踝之上3寸，胫骨之后。

神经分布：隐神经及胫神经。

针灸疗法：针3—4分深，灸2—5分钟。

治疗病症：小儿麻痹症、舞蹈病、夜间遗尿症、膀胱痉挛、膀胱麻痹、神经衰弱、失眠。

4. 阴陵泉

定穴法：膝下2寸，胫骨后缘。

神经分布：隐神经及胫神经。

针灸疗法：针3—5分深，灸2—3分钟，不宜多灸。

治疗病症：小儿麻痹症、夜间遗尿症、膀胱痉挛、膀胱麻痹、脚气病、失眠。

5. 血海

定穴法：在大腿内侧，髌骨上缘之上1寸处。

神經分布：隱神經及股神經。

針灸療法：針3—4分深，灸2—5分鐘。

治療病症：小兒麻痺症。

6. 箕門

定穴法：在大腿內側，膝上6寸。

神經分布：股神經及閉孔神經。

針灸療法：針3—5分深，灸2—5分鐘。

治療病症：小兒麻痺症、夜間遺尿症、尿閉。

7. 大橫

定穴法：臍旁開4寸處。

神經分布：肋間神經。

針灸療法：針3—5分深，灸2—5分鐘。

治療病症：習慣性便秘。

(五) 手少陰心經穴：

1. 少海

定穴法：肘橫紋的尺側端(內端)。

神經分布：臂內側皮神經及前臂內側皮神經。

針灸療法：針2—3分深，灸2—5分鐘。

治療病症：肋間神經痛、小兒麻痺症。

2. 靈道

定穴法：在尺骨下部之前內側，掌后1寸5分處。

神經分布：尺神經及前臂內側皮神經。

針灸療法：針3分深，灸2—5分鐘。

治療病症：小兒麻痺症、尺神經麻痺、癱瘓、肘關節炎。

3. 通里

定穴法：掌后尺側，腕上1寸。

神經分布：尺神經及前臂內側皮神經。

針灸療法：針3分深，灸2—5分鐘。

治療病症：頭痛、眩暈、神經性心悸亢進、急性扁桃腺炎、癰病。

4. 神門

定穴法：掌后尺側，腕橫紋之尺側端。

神經分布：尺神經及前臂內側皮神經。

針灸療法：針3分深，灸2—5分鐘。

治療病症：尺神經麻痺、精神病、失眠、神經性心悸亢進、舞蹈病、小兒驚厥、癲癇、急性扁桃腺炎。

5. 少沖

定穴法：在小指橈側，去爪甲角1分處。

神經分布：尺神經之分枝。

針灸療法：針1分深，灸2—3分鐘。

治療病症：小兒驚厥、喉頭炎、肋間神經痛、神經性心悸亢進。

(六) 手太陽小腸經穴：

1. 少澤

定穴法：小指尺側，指甲旁1分處。

神經分布：來自尺神經之指掌側固有神經。

針灸療法：針1分深，灸2—3分鐘。

治療病症：小兒驚厥、急性扁桃腺炎、頭痛。

2. 肩貞

定穴法：肩關節后下方，直對腋縫。

神經分布：腋神經，臂背側皮神經，臂內側皮神經及肋間神經外側皮枝。

針灸療法：針5分深，灸2—3分鐘。

治療病症：小兒麻痺症、肩關節炎。

3. 听宫

定穴法：耳珠之前方凹陷处。

神經分布：三叉神經第三枝之耳顳神經。

針灸療法：針1—2分深，灸2—5分鐘。

治疗病症：耳聾、耳鳴。

(七) 足太陽膀胱經穴：

1. 睛明

定穴法：距眼內眦角1分处。

神經分布：三叉神經第一枝的滑車下神經。

針灸療法：針1分深，禁灸。

治疗病症：急性結合膜炎、夜盲。

2. 攢竹

定穴法：在眉头。

神經分布：三叉神經第一枝的額神經。

針灸療法：針1—2分深，禁灸。

治疗病症：夜盲、額神經痛、眩暈。

3. 天柱

定穴法：后发际正中处之瘰癧穴兩旁之凹陷处。

神經分布：第三枕神經。

針灸療法：針3分深，灸2—5分鐘。

治疗病症：舞蹈病、癲癇、神經衰弱、头痛、項部疼痛难以回顧。

4. 大杼

定穴法：第一与第二胸椎棘突間的兩旁1寸半处。

神經分布：胸神經的后枝，肩胛背神經及副神經。

針灸療法：針1—2分深，灸2—5分鐘。

治疗病症：支气管喘息、急性支气管炎、慢性支气管炎、

喘息性支气管炎、小儿麻痹症、癲癇。

5. 风門

定穴法：第二与第三胸椎棘突間的兩旁1寸半处。

神經分布：胸神經后枝及肩胛背神經。

針灸療法：針1—2分深，灸2—5分鐘。

治疗病症：支气管喘息、支气管炎、小儿麻痹症。

6. 肺俞

定穴法：第三与第四腰椎棘突間的兩旁1寸半处。

神經分布：胸神經后枝，肩胛背神經及副神經。

針灸療法：針1—2分深，不可深刺；灸2—5分鐘。

治疗病症：支气管喘息、支气管炎。

7. 脾俞

定穴法：第十一与第十二胸椎棘突間兩旁1寸半处。

神經分布：胸神經后枝。

針灸療法：針2—3分深，灸2—5分鐘。

治疗病症：胃痙攣。

8. 胃俞

定穴法：第十二胸椎棘突与第一腰椎棘突間的兩旁1寸半处。

神經分布：胸神經后枝。

針灸療法：針3分深，灸2—5分鐘。

治疗病症：急性胃炎、慢性胃炎、胃痙攣、消化不良。

9. 三焦俞

定穴法：第一与第二腰椎棘突間的兩旁1寸半处。

神經分布：腰神經的后枝。

針灸療法：針3分深，灸2—5分鐘。

治疗病症：胃痙攣、消化不良、食欲减退、急性肾炎、夜間

遺尿症、腰痛、小兒麻痺症。

10. 腎俞

定穴法：第二與第三腰椎棘突間的兩旁1寸半處。

神經分布：腰神經的后枝。

針灸療法：針3—5分深，灸2—5分鐘。

治療病症：小兒麻痺症、腰痛、夜間遺尿症、膀胱痙攣、膀胱麻痺、急性腎炎。

11. 氣海俞

定穴法：第三與第四腰椎棘突間的兩旁1寸半處。

神經分布：腰神經的后枝。

針灸療法：針3—5分深，灸2—5分鐘。

治療病症：小兒麻痺症、腰痛。

12. 大腸俞

定穴法：第四與第五腰椎棘突間兩旁1寸半處。

神經分布：腰神經的后枝。

針灸療法：針3—5分深，灸2—5分鐘。

治療病症：小兒麻痺症、腰神經痛、單純性消化不良、習慣性便秘、夜間遺尿症、急性腎炎、腳氣病。

13. 關元俞

定穴法：第五腰椎棘突之下，旁開1寸半。

神經分布：腰神經后枝。

針灸療法：針3—5分深，灸2—5分鐘。

治療病症：小兒麻痺症、腰神經痛、膀胱肌麻痺。

14. 上髎

定穴法：在第一骶骨后孔處。

神經分布：骶神經的后枝。

針灸療法：針3—5分深，灸2—5分鐘。

治疗病症：小儿麻痹症、腰痛、便秘、尿闭。

15. 次髎

定穴法：在第二骶骨后孔处。

神经分布：骶神经的后枝。

针灸疗法：针3—5分深，灸2—5分钟。

治疗病症：小儿麻痹症、腰痛、便秘、尿闭。

16. 中髎

定穴法：在第三骶骨后孔处。

神经分布：骶神经的后枝。

针灸疗法：针3—5分深，灸2—5分钟。

治疗病症：小儿麻痹症、腰痛、便秘、尿闭。

17. 下髎

定穴法：在第四骶骨后孔处。

神经分布：骶神经的后枝。

针灸疗法：针3—5分深，灸2—5分钟。

治疗病症：小儿麻痹症、便秘、尿闭。

18. 承扶

定穴法：臀下横纹之中点。

神经分布：坐骨神经，臀下神经及股后皮神经。

针灸疗法：针3—8分深，灸1—2分钟。

治疗病症：小儿麻痹症、坐骨神经痛。

19. 殷门

定穴法：在臀横纹下6寸。

神经分布：坐骨神经及股后皮神经。

针灸疗法：针3—7分深，灸1—2分钟。

治疗病症：小儿麻痹症、坐骨神经痛。

20. 委中

定穴法：臑窩中央。

神經分布：脛神經及股后皮神經。

針灸治療：針3—5分深，不宜灸。

治療病症：小兒麻痺症、坐骨神經痛、腰痛、風濕性膝關節炎、嘔吐、腹瀉。

21. 承山

定穴法：在小腿後面正中，小腿肚下。

神經分布：脛神經及腓腸內側皮神經。

針灸療法：針5—7分深，灸2—5分鐘。

治療病症：小兒麻痺症、腓腸肌痙攣、腳氣病、嘔吐、腹瀉、便秘。

22. 崑崙

定穴法：外踝之後方凹陷處。

神經分布：腓淺神經。

針灸療法：針3分深，灸2—5分鐘。

治療病症：小兒麻痺症、坐骨神經痛、腳氣病、風濕性踝關節炎。

23. 申脈

定穴法：在外踝之下方凹陷處，赤白肉際。

神經分布：來自脛神經的跖外側神經。

針灸療法：針3分深，灸1—2分鐘。

治療病症：小兒麻痺症。

24. 至陰

定穴法：在足小趾外側，距趾甲1分處。

神經分布：來自腓腸神經的第五趾背神經。

針灸療法：針1分深，灸2—3分鐘。

治療病症：尿閉。

(八) 足少阴肾经穴:

1. 涌泉

定穴法: 在足心凹陷处。

神经分布: 跖内侧神经与跖外侧神经。

针灸疗法: 针3分深, 灸2—5分钟。

治疗病症: 小儿惊厥、失语症、急性扁桃腺炎。

2. 太谿

定穴法: 在内踝之后凹陷处。

神经分布: 胫神经及小腿内侧皮神经。

针灸疗法: 针3分深, 灸2—5分钟。

治疗病症: 小儿麻痹症。

3. 复溜

定穴法: 内踝之上2寸, 交信穴后5分。

神经分布: 胫神经及腓肠内侧皮神经。

针灸疗法: 针3分深, 灸2—5分钟。

治疗病症: 小儿麻痹症、盗汗。

4. 交信

定穴法: 内踝之上2寸, 胫骨后缘处。

神经分布: 胫神经及隐神经。

针灸疗法: 针3分深, 灸2—5分钟。

治疗病症: 小儿麻痹症、尿闭、便秘。

5. 幽门

定穴法: 脐上6寸之巨阙穴旁开5分处。

神经分布: 肋间神经前皮枝。

针灸疗法: 针2—5分深, 灸2—5分钟。

治疗病症: 胃痉挛、呕吐。

(九) 手厥阴心包络经穴:

1. 曲澤

定穴法：肘窩橫紋中央稍偏于尺側處，在尺澤與少海兩穴之間。

神經分布：正中神經 臂內側皮神經及前臂內側皮神經。

針灸療法：針2—3分深，灸2—5分鐘。

治療病症：支氣管炎、嘔吐。

2. 間使

定穴法：手腕掌側橫紋正中之上3寸處，當橈骨與尺骨之間。

神經分布：正中神經，前臂內側皮神經及前臂外側皮神經。

針灸療法：針3分深，灸2—5分鐘。

治療病症：小兒麻痺症、小兒驚厥、精神病、胃炎。

3. 內關

定穴法：手腕掌側橫紋正中之上2寸處，橈骨與尺骨之間。

神經分布：正中神經，前臂內側皮神經及前臂外側皮神經。

針灸療法：針3分深，灸2—5分鐘。

治療病症：胃神經痛、幽門痙攣、單純性消化不良、小兒麻痺症。

4. 中沖

定穴法：中指之尖端，距指甲1分處。

神經分布：正中神經的指掌側總神經。

針灸療法：針1分深，灸1分鐘。

治療病症：休克、暈厥、虛脫、小兒驚厥。

(十) 手少陽三焦經穴：

1. 关冲

定穴法：在无名指的尺侧，距指甲1分处。

神经分布：来自尺神经的指掌侧固有神经。

针灸疗法：针1分深，灸2—3分钟。

治疗病症：小儿惊厥。

2. 外关

定穴法：在手腕背侧腕横纹之上2寸，桡骨与尺骨之间。

神经分布：桡神经与前臂背侧皮神经。

针灸疗法：针3—5分深，灸2—5分钟。

治疗病症：小儿麻痹症、风湿性腕关节炎、风湿性肘关节炎、耳聾、齿痛。

3. 支沟

定穴法：在手腕背侧腕横纹之上3寸，桡骨与尺骨之间。

神经分布：桡神经及前臂背侧皮神经。

针灸疗法：针3—5分深，灸2—5分钟。

治疗病症：小儿麻痹症、舞蹈病、肋间神经痛、习惯性便秘。

4. 肩髃

定穴法：在肩关节后方，肩髃穴后下1寸处。

神经分布：肩胛上神经及臂背侧皮神经。

针灸疗法：针3分深，灸2—5分钟。

治疗病症：小儿麻痹症、风湿性肩关节炎。

5. 翳风

定穴法：耳垂后方凹陷处。

神经分布：耳大神经及颜面神经。

针灸疗法：针3分深，灸2—5分钟。

治疗病症：颜面神经麻痹、耳聾、耳鳴。

6. 耳門

定穴法：耳珠之前上方。

神經分布：三叉神經第三枝的耳顳神經。

針灸療法：針2分深，灸2—5分鐘。

治療病症：耳聾、耳鳴、牙痛。

7. 絲竹空

定穴法：在眉梢。

神經分布：三叉神經第一枝的額神經，顏面神經。

針灸療法：針2—3分深，禁灸。

治療病症：顏面神經麻痺、急性結合膜炎、頭痛、眩暈。

(十一) 足少陽胆經穴：

1. 瞳子髎

定穴法：眼外眦之旁5分處。

神經分布：顏面神經及三叉神經的第一、二枝。

針灸療法：針2分深，灸2—3分鐘。

治療病症：顏面神經麻痺、顏面神經痙攣、三叉神經痛、急性結合膜炎。

2. 听会

定穴法：耳珠之前下方。

神經分布：顏面神經及耳大神經。

針灸療法：針2—3分深，灸2—5分鐘。

治療病症：顏面神經麻痺、顏面神經痙攣、牙痛、耳聾、耳鳴。

3. 阳白

定穴法：眉毛中部之上1寸，眼直視時瞳孔的上方。

神經分布：眶上神經，顏面神經。

針灸療法：針1—2分深，灸2—3分鐘。

治疗病症：顏面神經麻痺、顏面神經痙攣、三叉神經痛。

4. 风池

定穴法：后发际正中点上1寸处风府穴之兩旁凹陷处。

神經分布：枕大神經及枕小神經。

針灸疗法：針3—5分深，灸2—5分鐘。

治疗病症：舞蹈病、神經衰弱、头痛、小儿惊厥。

5. 肩井

定穴法：在崗上窩中央，大椎穴(第七頸椎与第一胸椎棘突間)与肩髃穴(有肩端)連線之中点。

神經分布：鎖骨上神經及副神經。

針灸疗法：針2—4分深，禁深刺；灸2—5分鐘。

治疗病症：小儿麻痹症。

6. 环跳

定穴法：取穴时，側卧；伸直下面的腿，屈上面的腿。环跳穴正当股骨大粗隆，坐骨結节与髂后上棘联成的三角形的中心。

神經分布：分布臀上神經，臀下神經及臀中皮神經，深部为坐骨神經穿出坐骨大孔处。

針灸疗法：針1—2寸深，灸2—5分鐘。

治疗病症：小儿麻痹症、坐骨神經痛、脚气病。

7. 风市

定穴法：在大腿外側，直立，兩手下垂复于大腿外側时，中指尽处是穴。

神經分布：股外側皮神經。

針灸疗法：針5分深，灸2—5分鐘。

治疗病症：小儿麻痹症、舞蹈病、风湿性膝关节炎、脚气病、蕁麻疹。

8. 中瀼

定穴法：在大腿外侧，膝上5寸。

神经分布：股外侧皮神经。

针灸疗法：针5分深，灸2—5分钟。

治疗病症：小儿麻痹症、脚气病。

9. 阳陵泉

定穴法：腓骨小头之前下方凹陷处。

神经分布：分布腓肠外侧皮神经，当腓总神经分为腓浅神经与腓深神经之分歧处。

针灸疗法：针4—5分深，灸2—5分钟。

治疗病症：小儿麻痹症、坐骨神经痛、小儿惊厥、舞蹈病、风湿性膝关节炎、习惯性便秘。

10. 光明

定穴法：外踝之上5寸。

神经分布：腓浅神经及腓肠外侧皮神经。

针灸疗法：针5分深，灸2—5分钟。

治疗病症：脚气病、小儿麻痹症。

11. 阳辅

定穴法：外踝之上4寸。

神经分布：腓浅神经与腓肠外侧皮神经。

针灸疗法：针3—5分深，灸2—5分钟。

治疗病症：小儿麻痹症、脚气病、膝关节炎。

12. 悬钟

定穴法：外踝之上3寸。

神经分布：腓浅神经与腓肠外侧皮神经。

针灸疗法：针4—5分深，灸2—5分钟。

治疗病症：小儿麻痹症、脚气病。

13. 丘墟

定穴法：外踝前下方凹陷处。

神經分布：腓淺神經。

針灸療法：針3—5分深，灸2—5分鐘。

治療病症：小兒麻痺症、腳氣病。

14. 竅陰

定穴法：足第四趾外側，去爪甲角1分处。

神經分布：來自腓淺神經的趾背神經。

針灸療法：針1分深，灸2—3分鐘。

治療病症：嘔逆。

(十二) 足厥陰肝經穴：

1. 大敦

定穴法：足躡趾外側，距趾甲約1分处。

神經分布：趾背神經。

針灸療法：針1分深，灸2—5分鐘。

治療病症：遺尿、便秘、腰痛。

2. 行間

定穴法：在足躡趾與次趾之間的趾縫凹陷处。

神經分布：腓深神經。

針灸療法：針3分深，灸2—5分鐘。

治療病症：小兒驚厥、牙痛、遺尿、便秘。

3. 太冲

定穴法：在第一與第二跖骨間，足大趾本节後1寸半。

神經分布：腓深神經。

針灸療法：針3分深，灸2—5分鐘。

治療病症：腰痛。

4. 中封

定穴法：在內踝之前1寸，微下，当解谿穴与商丘穴之間。

神經分布：来自腓淺神經的足背內側皮神經及隱神經。

針灸療法：針3—4分深，灸2—5分鐘。

治疗病症：小儿麻痺症。

(十三) 督脉經穴：

1. 阳关

定穴法：第四与第五腰椎棘突之間。

神經分布：腰神經的后枝。

針灸療法：針3分深，灸2—5分鐘。

治疗病症：小儿麻痺症、腰神經痛。

2. 命門

定穴法：第二与第三腰椎棘突之間。

神經分布：腰神經的后枝。

針灸療法：針3分深，灸2—5分鐘。

治疗病症：小儿麻痺症、腰痛、夜間遺尿症。

3. 中樞

定穴法：第十与第十一胸椎棘突之間。

神經分布：胸神經的后枝。

針灸療法：針3分深，灸2—5分鐘。

治疗病症：小儿麻痺症。

4. 身柱

定穴法：第三与第四胸椎棘突之間。

神經分布：胸神經的后枝。

針灸療法：針3分深，灸2—5分鐘。

治疗病症：癲癇、小儿惊厥、小儿夜惊症、舞蹈病、支气管
炎。

5. 陶道

定穴法：第一与第二胸椎棘突之間。

神經分布：頸神經后枝及胸神經后枝。

針灸療法：針4分深，灸2—5分鐘。

治疗病症：小儿麻痺症、神經衰弱、疟疾。

6. 大椎

定穴法：第七頸椎棘突与第一胸椎棘突之間。

神經分布：頸神經的后枝。

針灸療法：針2—4分深，灸2—5分鐘。

治疗病症：小儿麻痺症、小儿惊厥、癲癇、精神病、舞蹈病、疟疾。

7. 瘈門

定穴法：后发际之正中，第一与第二頸椎之間。

神經分布：第三枕神經。

針灸療法：針2—3分深，禁深刺；禁灸。

治疗病症：失語症。

8. 风府

定穴法：后发际正中点上1寸处，亦即瘈門穴上1寸处。

神經分布：枕大神經及第三枕神經。

針灸療法：針2—3分深，禁深刺，因深部有延髓；禁灸。

治疗病症：头痛、頂部神經痛、精神病。

9. 百会

定穴法：眉間（印堂穴）之上7寸5分处取穴时，从兩耳尖直上，在头頂正中綫上取之。

神經分布：枕大神經。

針灸療法：針2—3分深，灸2—5分鐘。

治疗病症：小儿夜惊症、小儿惊厥、癲癇、神經衰弱、头

痛、眩暈、脫肛。

10. 上星

定穴法：在眉間之上3寸5分。

神經分布：三叉神經第一枝的額神經。

針灸療法：針2分深，灸2—5分鐘。

治療病症：前額神經痛、鼻炎、額竇炎、衄血。

11. 神庭

定穴法：眉間之上3寸。

神經分布：三叉神經第一枝的額神經。

針灸療法：針2分深，灸2—5分鐘。

治療病症：前額神經痛、眩暈、急性鼻炎。

12. 人中

定穴法：鼻下，陷中。

神經分布：三叉神經第二枝及顏面神經。

針灸療法：針2—3分深，灸2—5分鐘。

治療病症：休克、暈厥、小兒驚厥、癲癇、顏面神經麻痺、精神病。

(十四) 任脈經穴：

1. 中極

定穴法：臍下4寸。

神經分布：髂腹下神經及第十二肋下神經前皮枝。

針灸療法：針5—8分深，灸2—5分鐘。

治療病症：夜間遺尿症、膀胱括約肌麻痺、尿頻（膀胱痙攣）、膀胱麻痺。

2. 關元

定穴法：臍下3寸。

神經分布：肋間神經前皮枝。

針灸療法：針5—8分深，灸2—5分鐘。

治療病症：夜間遺尿症、膀胱痙攣、膀胱麻痺、單純性消化不良。

3. 氣海

定穴法：臍下1寸5分。

神經分布：肋間神經前皮枝。

針灸療法：針5—7分深，灸2—5分鐘。

治療病症：夜間遺尿症。

4. 神闕

定穴法：臍窩之中央。

神經分布：肋間神經前皮枝。

針灸療法：禁針，灸2—5分鐘。

治療病症：單純性消化不良。

5. 下脘

定穴法：臍上2寸。

神經分布：肋間神經前皮枝。

針灸療法：針5—8分深，灸2—5分鐘。

治療病症：消化不良、胃痙攣、胃炎。

6. 中脘

定穴法：臍上4寸。

神經分布：肋間神經前皮枝。

針灸療法：針3—5分深，灸2—5分鐘。

治療病症：消化不良、急性胃炎、慢性胃炎、胃痙攣、胃及十二指腸潰瘍、幽門痙攣。

7. 上脘

定穴法：臍上5寸。

神經分布：肋間神經前皮枝。

針灸療法：針3—5分深，灸2—5分鐘。

治療病症：消化不良、急性胃炎、慢性胃炎、胃痙攣。

8. 巨關

定穴法：臍上6寸。

神經分布：肋間神經前皮枝。

針灸療法：針3—5分深，灸2—5分鐘。

治療病症：胃痙攣、橫膈膜痙攣。

9. 天突

定穴法：喉結之下方，胸骨柄頸切迹上緣之中央凹陷處。

神經分布：頸皮神經。

針灸療法：針尖向后下方刺2—3分深，不宜深刺。灸2—5分鐘。

治療病症：支氣管喘息、喉炎、扁桃腺炎、神經性嘔吐。

10. 承漿

定穴法：下唇的下方，頰唇溝之中央凹陷處。

神經分布：三叉神經第三枝的頰神經。

針灸療法：針2—3分深，灸2—5分鐘。

治療病症：顏面神經麻痺、齒神經痛、癱瘓。

(十五) 經外奇穴：

1. 太陽

定穴法：眉梢外下一橫指凹陷處。

針灸療法：針1—2分深，禁灸。

治療病症：頭痛、頭暈、急性結合膜炎。

2. 印堂

定穴法：兩眉之間的正中。

針灸療法：針1—2分深，灸2—5分鐘。

治療病症：小兒驚厥、額竇炎、頭痛、眩暈。

3. 椎頂

定穴法：第六頸椎与第七頸椎之間。

針灸療法：針 1—2 分深，灸 2—5 分鐘。

治療病症：小兒麻痺症、疟疾。

4. 椎旁

定穴法：此系作者所发现的一个新穴，部位系在第七頸椎棘突与第一胸椎棘突之間旁开 1 寸半处，亦即大椎穴之兩旁 1 寸半处。

針灸療法：針 1—2 分深，灸 2—5 分鐘。

治療病症：小兒麻痺症、支气管喘息。

5. 椎間

定穴法：此系作者所发现之另外一个新穴，部位系在第十二胸椎棘突与第一腰椎棘突之間。

針灸療法：灸 2—5 分鐘。

治療病症：小兒麻痺症。

6. 下极之俞

定穴法：第三腰椎棘突与第四腰椎棘突之間。

針灸療法：灸 2—5 分鐘。

治療病症：小兒麻痺症、腰神經痛。

7. 四縫

定穴法：兩手之食指、中指、环指及小指掌面之第一指节与第二指节間橫紋正中。

針灸療法：淺刺 1 分深。

治療病症：單純性消化不良。

8. 十宣

定穴法：在手十指之尖端，距指甲 1 分处，共十穴(其中兩側中指尖端二穴与中冲穴同一部位)。

針灸療法：用速刺法針1分深(出血)。

治療病症：小兒驚厥、休克、暈厥、虛脫、扁桃腺炎。

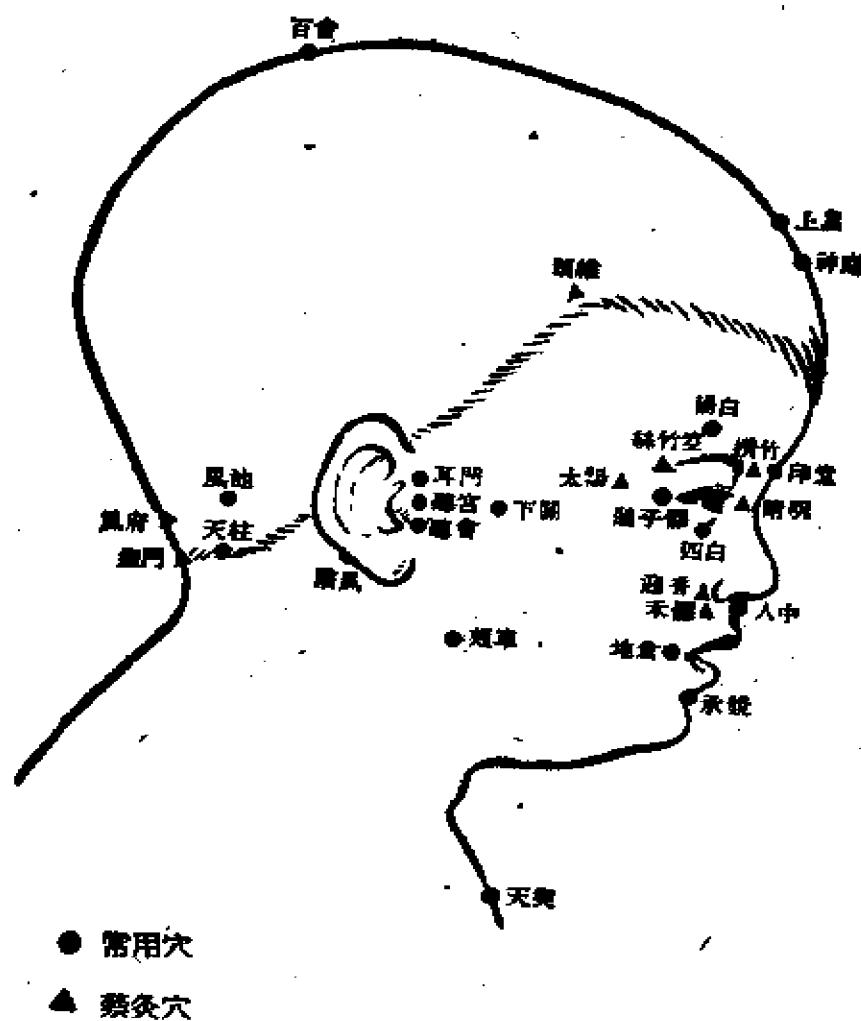


图6 头颈部常用穴位图

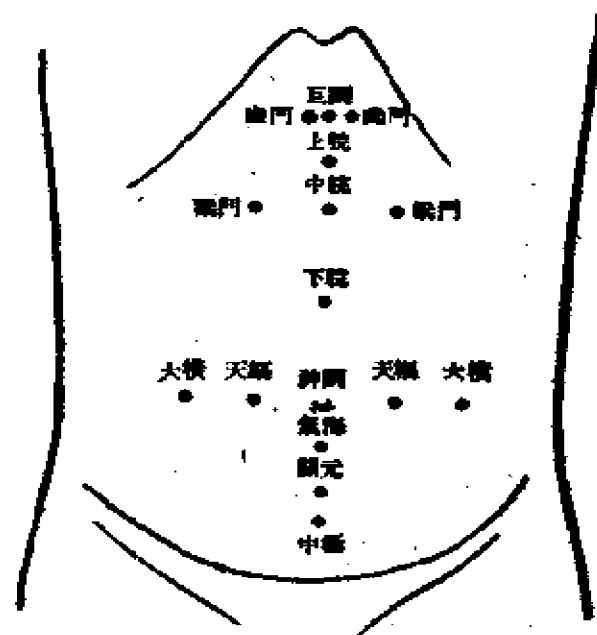


图7 腹部常用穴位图

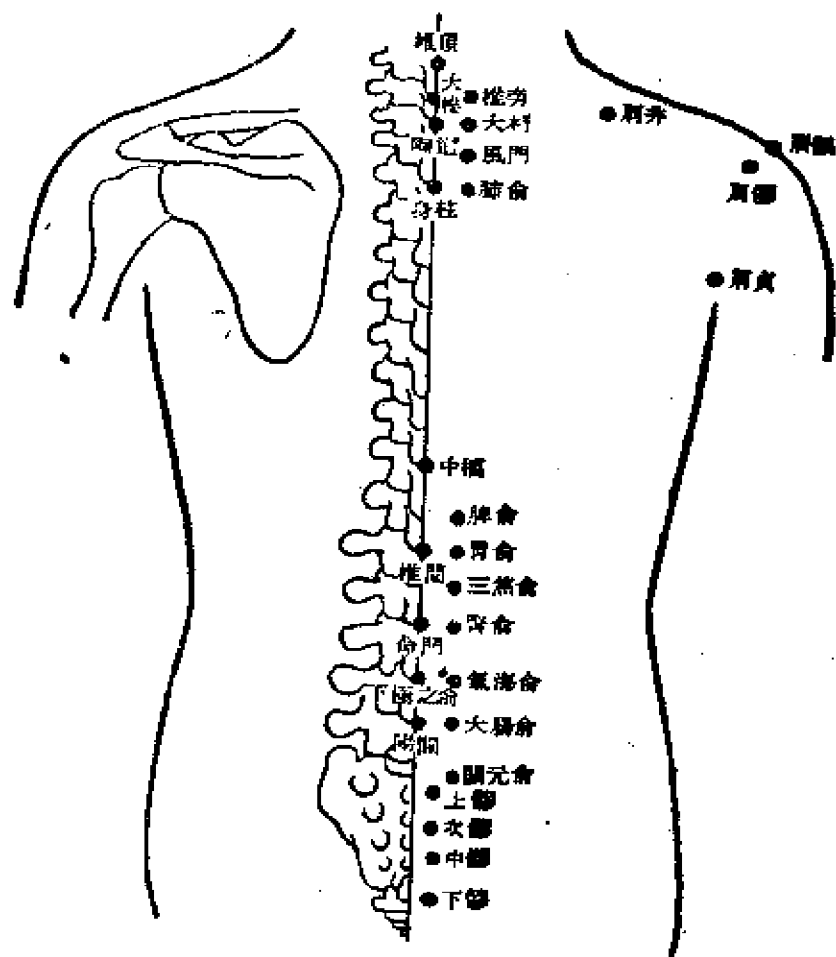


图 8 肩胛部及背部常用穴位

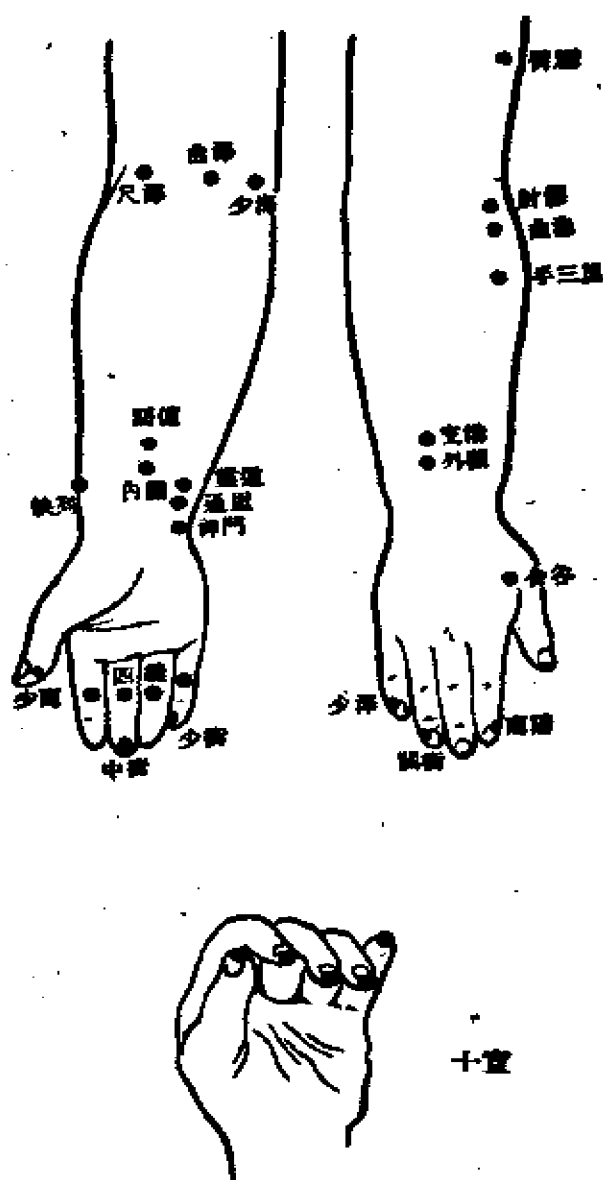


图9 上肢常用穴位图

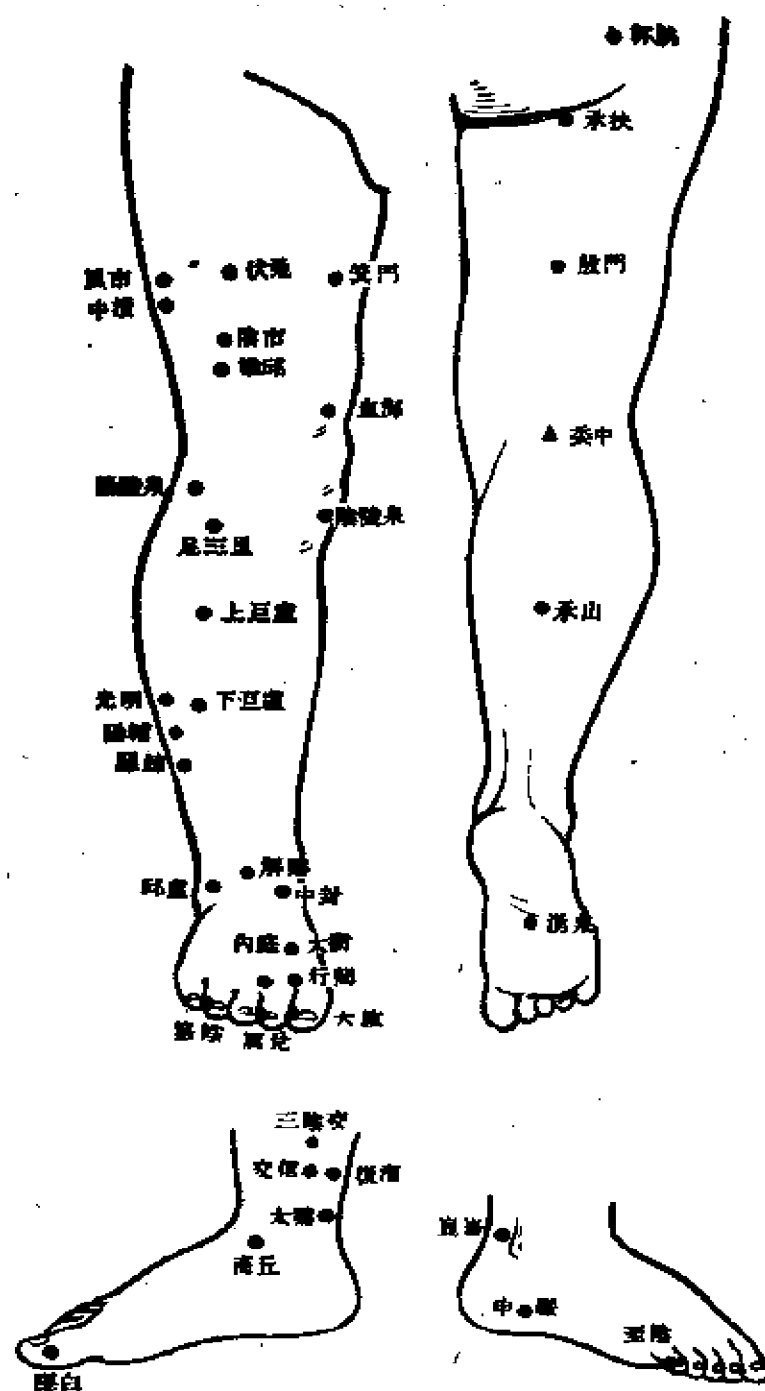


图 10 下肢常用穴位图

第五章 治療總論

一、針灸療法在小兒科的適應症與禁忌症

針灸療法對很多種兒科病症確有療效，能起到主治作用。凡是經針灸治療能達到全愈或好轉的病症，都可以說是針灸的適應症。例如：小兒麻痺症、顏面神經麻痺、失語症、休克、小舞蹈症、風濕性關節炎、急性胃炎、慢性胃炎、胃或十二指腸潰瘍、胃痙攣、小兒幽門痙攣、單純性消化不良、習慣性便秘、夜間遺尿症、膀胱痙攣及膀胱麻痺等兒科病症，經過針灸治療後，可能痊癒、近愈、顯著好轉或好轉。凡必須用外科手術、特效藥物或其他療法治療的病症，都可以說是針灸的禁忌症。例如：腸套迭、骨折及氣管異物等。

二、針灸治療的基本法則

針灸療法是祖國寶貴醫學遺產之一。靈樞經脈篇：“盛則瀉之，虛則補之，熱則疾之，寒則留之，陷下則灸之，不盛不虛，以經取之。”就是針灸治療病症的基本法則。針灸治療時，必須遵守“虛則補之，實者瀉之，”的原則。對於小兒麻痺症及顏面神經麻痺等“虛症”應當施行“補”的手法，給予弱刺激，以便達到興奮的作用。對於顏面神經痙攣、舞蹈病及神經痛等“實症”則應施行“瀉”的手法，給予比較強的刺激，以便達到抑制作用。對於不實不虛的病症，則應施行“平補平瀉”的手法，給予中等度的刺激。對於“熱症”宜以速刺法，急出其針，以瀉其熱；若速刺後放出一點血出來，往往效果更好些。對於“寒症”，則應留針。對於虛甚而致氣陷下者則應灸之。

針灸治療時，宜根據病症的輕重緩急，治分先後。在一般情況下，應當根據“治病必求其本”的原則，先治本病，後治標病。若標病為急症，對病人危害甚大，則應根據“急則治其標，緩則治其本”的原則，先治標病，後治本病。

針灸治療時，必須根據病歷、診查結果與診斷，選擇適當的穴位，才能收到良好的效果。針灸處方時，常用的取穴法有：

(一) **局部取穴**：在患病部位的局部或其附近取穴。例如：耳病時可取耳門、听宮、听會及翳風等穴；鼻病可取迎香及印堂等穴；眼病可取睛明及瞳子髎等穴；胃病時可取上脘及中脘等穴；肘關節病可取曲池等穴。

(二) **遠隔取穴**：在距患病部位較遠的部位取穴，叫做遠隔取穴。在針灸臨床治療時，遠隔穴多與上述的局部穴配合應用。採取遠隔穴時，多遵行“循經取穴”的原則，採用上肢肘以下的腧穴或下肢膝以下的腧穴。取穴時，可以在本經取穴，亦可取與發病本經互為表里之異經經穴治療；本經與異經同時取穴，互相配合亦可。常用的配穴法有：

1. **局部穴與遠隔穴相互配合法**：即局部穴與遠隔穴配合應用。例如：針治顏面神經麻痺時，不但取顏面部的听會、下關、瞳子髎、頰車及地倉等局部穴，而且應配合距離患病部位較遠的手上的合谷穴。又如：針治急性胃炎時，取腹部的中脘穴與下肢的足三里穴配合，效果很好。

2. **俞募相配法**：即背部的俞穴與胸腹部的募穴互相配合。例如：針治急性胃炎、胃神經痛或胃潰瘍等胃部疾患時，取背部的胃俞與腹部的募穴中脘配合應用，往往收到很好的效果。

3. **原絡相配法**：採取發病本經的原穴為主，並取與發病

本經互為表里之經的絡穴為客，互相配合，叫做原絡相配法。例如：手陽明大腸經若有病，宜採取手陽明大腸經的原穴合谷為主，並取與手陽明大腸經互為表里之手太陰肺經的絡穴列缺為客，互相配合。

針治時，宜盡力爭取“氣至”，以便得到良好的效果。標幽賦云：“氣速至而速效，氣遲至而不治。”由此可見，針治時，能否得到“氣至”與針治的效果有極密切的關係。因此，針治者應積極鉅研針治的手法，提高針灸治療的醫療質量，以便得到更好的療效。

針灸治療時，除應根據病情與診斷採用適當的穴位，並給予適當的刺激外，更應爭取在早期施行針灸治療，才能得到較高的療效。例如：小兒麻痺症患儿若能於燒退及腦脊髓液細胞數恢復或接近正常時，即能及早開始針灸治療，往往能得到很好或相當好的效果；若等到癱瘓已數年，肢體已有畸形，才開始針灸治療，其療效則較低。因此，小兒麻痺症患儿的針灸治療，應當及早開始。又如：單純性消化不良患儿，若能及早採用針灸治療，效果很好；不但痊癒率高，而且很多患兒於針灸治療後可能好得很快；若針灸治療開始得過晚，則其療效遠不如及早開始針灸治療者那樣好。

第六章 治療各論

一、小兒麻痺症

小兒麻痺症又名脊髓前角灰質炎，也叫做嬰兒癱瘓，系由於特异性濾過性病毒所引起的一種傳染病。其特征為發燒，並可能發生分布不整齊的弛緩性麻痺。因為對於本病尚無特

效疗法,因而在过去有很多患儿致瘫痪,甚至终身成为残废。为了想解除或减轻患儿疾苦,作者于1953年7月开始试用针灸治疗此病。自从健康报及新华社于1954年及1955年报导了北京市儿童医院“应用针灸治疗小儿麻痹症获得良好效果”;中华儿科杂志于1955年及1956年发表了作者所写的“针灸疗法在小儿科的应用”及“针灸治疗小儿麻痹症及其后遗症的体会”等论文后,曾引起很多人的重视,针灸治疗小儿麻痹症的工作得以在党和政府的支持下广泛地开展起来,使很多患儿得到了针灸治疗的好处。

病因: 小儿麻痹症主要见于6个月到5岁小儿;最常发生于夏秋两季,以6—10月之间发病者最多。

小儿麻痹症的病原是一种特异性滤过性病毒。它虽微小,但生活力却很强,在水及牛奶内可生存一百多天,在粪便中可生存更久些。病人的粪便可带有病毒1—2星期,甚至5—6星期或更久。

主要传染途径是由胃肠道感染,或借病人粪便、被病人污染的食物或用具等传染;通过飞沫亦可能感染。在发病最初的三至五天內,亦可自鼻咽腔感染病毒,但并非本病的主要传染途径。小儿麻痹症的病毒主要侵害脊髓前角的灰质,脊髓的腰段与颈段最易受到感染。

症状: 一般潜伏期约持续1至2星期,但亦可短至2天,



图11 小儿麻痹症的上肢弛缓性麻痹



图 12 小儿麻痹症的下肢麻痹

长至 35 天之久。病程可分为先驅期、瘫痪前期、瘫痪期、恢复期及后遗症期。兹将各期症候分述如下：

(一) 先驅期：发烧，体温約在 $38-39^{\circ}\text{C}$ 左右，全身不适、輕度咽痛，或有头痛、嘔吐等症。症状很象上呼吸道感染或胃腸病，因此很容易誤認。发烧 1—4 天后，燒退。患者的症状，若止于此期，即为頓挫型。有些病人是沒有前驅期的。

(二) 瘫痪前期：先驅期发烧退后，經過 1—6 天，发烧又起，并可能有嘔吐、咽痛、头痛、及出汗等症。患儿肢体疼痛且感觉過敏，不愿他人撫抱。克匿格 (Kernig) 氏征可能为阳性，体温多在 39°C 以下，发烧持續約 3—5 天或更久然后下降。若有瘫痪发生，大都在这次发烧 3—4 天后。若在此期作腰椎穿刺檢查脑脊髓液，多数患儿的脑脊髓液透明，压力稍增高，潘迪 (Pandy) 氏試驗阳性，糖量正常或稍多，氯化物

量亦正常。細胞數增加，每立方毫米約 15—200 個左右或較高，在極少數病例細胞數并不增加。燒退后，腦脊髓液細胞數迅速恢復正常，但球蛋白反應却能持續較久。患儿的症狀若止于癱瘓前期，則為無癱瘓型。

（三）癱瘓期：癱瘓的發現，大都在癱瘓前期的第 3—4 天起始，有的病人可早至 1—2 天，亦可遲至 7—11 天才發現癱瘓，亦有極少數病人沒有其他症狀突然發現癱瘓的。癱瘓的範圍與嚴重程度可能繼續發展與加重，大都經過 1—10 天即不再進行，一般在患儿燒退后癱瘓即不再進展。癱瘓是弛緩性的，肌肉松弛、張力減低、肌力減退、反射消失或顯著減弱。癱瘓的分布很不整齊，是不對稱的。雖然兩下肢可同時均發生癱瘓，但是兩下肢癱瘓的嚴重程度還是有區別的。最常發生癱瘓的部位是下肢，其次為上肢。顏面神經麻痺亦較常見，但尚不如下肢癱瘓那樣常見。或僅一側下肢發生癱瘓，或兩側下肢均發生癱瘓；或一側上肢發生癱瘓，或一側的上肢與對側的下肢均發生癱瘓，或一側上肢與兩下肢癱瘓，或四肢同時癱瘓；同側上下肢都癱瘓及兩側上肢都癱瘓，但下肢正常者很少見。下肢肌肉之中，以脛骨肌、股四頭肌及腓骨肌最常發生癱瘓；在上肢則以三角肌最常發生癱瘓。癱瘓早期腦脊髓液仍可見顯著變化：白血球增多，潘迪氏反應陽性等。有時腦脊液細胞數雖已恢復正常，但潘迪氏試驗仍為陽性，甚至強陽性。

（四）恢復期：脊髓前角的細胞受侵的程度若不很重，發生麻痺的肌群即見逐漸恢復。恢復過程在最初三月內恢復較快，以後恢復就較慢，18 個月后則很少再有進步。

（五）後遺症期：有些患病的肌群，因為神經系病變太重，難以恢復，形成頑固性的癱瘓。患病肢體可發生肌肉萎

縮，肌肉攣縮及种种畸形：腕下垂、足下垂、足內翻、足外翻、仰趾足（鈎足）及膝反屈等。

針灸療法：急性期患儿宜卧床休息，避免疲劳。出現瘫痪后，發燒已退而且腦脊液細胞數恢复或已接近正常时，宜及早开始針灸治疗，因早期治疗，效果較好。实践証明針灸治疗若能及早开始，有促进麻痹肌肉恢复的作用。患儿每星期針治三次，每隔1—2天針治一次。每針治三个月定为一个疗程。一个疗程结束后，可休息1—2周后再繼續針治，若見患儿繼續有进步則亦可于針治一个疗程后繼續針治而不休息。病情較輕的于針灸治疗約1—5个月后即可能痊愈；病情严重的病例于針治半年至一年后可能痊愈、近愈或显著好轉；病情特別严重的病例需要針治一兩年以上，可能有进步，甚或可能显著好轉。患儿于針灸治疗后能否痊愈或显著好轉与患儿开始来針灸治疗的早晚，病情的严重程度及患儿能否遵照医嘱坚持繼續来作針灸治疗有极密切的关系。茲举出病情严重但好得較快及病情較輕的各一例供参考：

（一）病情严重但好得較快的病例：患儿李××，門診号73315，男，1岁9个月。于1954年7月来院初診时，主訴为右下肢瘫痪已8天。患儿于1954年7月17日开始發燒，燒3天后右下肢发生瘫痪。曾在某医院診查，并做腰椎穿刺查腦脊髓液，确診为小儿麻痹症，介紹来我院針灸治疗。檢查时見患儿右下肢有严重之弛緩性瘫痪、肌肉松弛、右膝反射消失，既不会站，更不会走。針治3次后即已会站，針治6次后能走7—8步，針治38次后，能走得很快很远很好，而且会跑与上下楼梯，右下肢肌肉已不松弛，右膝反射恢复，右下肢弛緩瘫痪完全恢复。共針治43次，結果痊愈。針治取穴：风市、阳陵泉、足三里、三阴交、大腸俞。

(二) 病情較輕的病例：患儿刘××，門診号 49589，男孩，1 岁半。于 1955 年 7 月来我院初診时，主訴为十多天来不会走路。患儿于 1955 年 6 月 23 日开始发燒，发燒 3 天后发现右腿不会走，不会站，也不会爬。曾在某医院診查，并會檢查腦脊髓液兩次，确診为小儿麻痹症，介紹来我院針灸。檢查时見右下肢呈弛緩性麻痹，右膝反射消失，不会站，更不会走。患儿經針治 3 次后，拉着一只手可以走十几步；針治 4 次后，会爬了，会自己站立，而且能自己走十多步；針治 12 次后，患儿已能走得很快很远很好，右膝反射恢复，右下肢弛緩性麻痹完全恢复。共針治 15 次，結果患儿于針治后迅速痊愈。針治取穴：风市、梁丘、阳陵泉、足三里、三阴交、大腸俞。

瘫痪已一兩年以上才开始来針灸治疗之小儿麻痹后遗症患儿，多半已有严重的畸形与肌肉萎縮，用針灸治疗大都已不可能痊愈；但确有些瘫痪已一兩年以上的小儿麻痹后遗症患儿于长期針灸治疗后有进步，甚至有出乎意料的显著好轉。这一事实使我們更加深刻地認識到針灸疗法对于小儿麻痹症确有疗效，使我們更加相信針灸疗法有促进与帮助麻痹肢体恢复的作用。例如：患儿时××，病历号 1957，男，四岁。于 1954 年 3 月 24 日来我院开始針灸治疗时，兩下肢瘫痪已兩年零七个月之久。患儿于 1951 年 8 月 9 日于发燒 5 天后兩下肢发生严重之弛緩性瘫痪，尤以左下肢瘫痪特別严重。檢查时見兩下肢均有肌肉萎縮，尤以左下肢肌肉萎縮更較严重。兩下肢均有严重畸形，兩脚均呈下垂內翻状。兩側下肢膝反射及跟腱反射均消失。不会爬、不会蹲、不会站、更不会走。根据病历及檢查所見，診断为小儿麻痹后遗症。經用針灸試治后，竟有出乎意料之效果：針治 3 次后，扶着会站；針治 6 次后，扶着会蹲，且会爬几步；針治 9 次后，扶着能走几步；針治

21次后，双手扶着一个高而輕的特制板凳能走相当远；針治73次后，扶杖已能走很远，不扶杖亦能走3—4步；繼續針灸治疗后；病情显著好轉，能独自行走很远。全家均甚感惊奇。

針治取穴：风市、梁丘、阳陵泉、足三里、阳輔、悬鍾、丘墟、解谿、崑崙、三阴交、委中、腎俞、大腸俞。并曾用回旋灸法灸椎間、命門及阳关穴，每次灸2—3分钟，作为輔助疗法。

根据北京市儿童医院針灸科自1953年7月至1958年7月，应用針灸治疗小儿麻痺症及其后遺症共815例的初步統計：

小兒麻痺症 及其后遺症	病例数	有 效				无进 步	痊癒、近癒、 显著好轉率	有效 率
		痊癒	近癒	显著 好轉	进步			
麻痺后在一年以內 即开始針灸治疗者	711	336	83	266	126	0	82.3%	100%
麻痺后在一年以上兩年 以內才开始針灸治疗者	43	2	3	14	24	0		
麻痺后在兩三年以上才 开始針灸治疗之后遺症	61	0	0	25	34	2		
總 計	815	238	86	305	184	2	77.2%	99.7%

作者于应用与研究針灸治疗小儿麻痺症及其后遺症的实际工作中，体会到下列各穴是小儿麻痺症的有效穴：

(一) 針治上肢麻痺取穴：

1. 常用穴：肩髃、肩貞、肩井、曲池、支沟、合谷、大椎与椎旁。

2. 备用穴：臂臑、尺澤、手三里、間使、內关、灵道、神門、外关、陶道。

(二) 針治下肢麻痺取穴：

1. 常用穴：梁丘、血海、阳陵泉、足三里、阳辅、三阴交、殷門、委中、腎俞、大腸俞。

2. 备用穴：伏兔、阴市、箕門、阴陵泉、上巨虛、下巨虛、光明、悬鍾、丘墟、解谿、中封、商丘、太冲、环跳、承扶、承山、崑崙、太溪、交信、三焦俞、气海俞、关元俞、上髎。

(三) 針治顏面神經麻痺取穴：

1. 常用穴：絲竹空、瞳子髎、下关、頰車、地仓、听会、合谷。

2. 备用穴：阳白、迎香、人中、翳风、列缺。

作者于应用針灸治疗小儿麻痺症的實踐中，体会到針治小儿麻痺症的有效手法是：捻轉进針，待“气至”后，再微捻数下，給針刺穴位以短時間的弱刺激，也就是給予“补”的手法，然后即刻捻轉退針。因为小儿麻痺症系属于“虛症”，故应根据“虛則补之”的原則，給予“补”的手法。

除針治外，亦可配合灸治法，作为輔助疗法。对于麻痺尙未超过三个月的小儿麻痺症，更为适宜。灸椎頂穴或大椎穴对上肢麻痺患儿是有好处的；灸中樞、椎間、命門、下极之俞或阳关穴，对患下肢麻痺的患儿是有帮助的。作者认为灸椎頂穴治疗患上肢麻痺之小儿麻痺症比灸大椎穴可能更为有效；因为上肢麻痺患儿的主要病变系在脊髓頸节，而椎頂穴較大椎穴离被侵犯的主要病变部位更为接近些。原因是頸髓节段比相应的脊椎高出一个椎骨。根据同样的原理，作者认为灸椎間或中樞穴治疗下肢麻痺症比灸阳关、下极之俞或命門穴可能更为有效，因为下肢麻痺的发生是因为病毒主要侵犯了脊髓腰节与骶节，而椎間或中樞穴較阳关、下极之俞或命門穴离主要被病毒侵犯的脊髓腰节与骶节更为接近。原因是脊髓腰节与骶节与椎骨更不相符，脊髓腰节位于第十、十一和十

二胸椎处；脊髓骶节位于第十二胸椎与第一腰椎处。

灸治时，除可采用上列各穴外，亦可灸下列各穴：

（一）上肢麻痹患儿亦可灸肩髃、肩贞、肩井、臂臑、曲池、手三里、支沟、外关、合谷、间使、内关、灵道、神门、陶道、椎旁等穴。

（二）下肢麻痹患儿亦可灸伏兔、阴市、梁丘、血海、箕门、阳陵泉、足三里、上巨虚、下巨虚、光明、阳辅、悬钟、丘墟、解溪、中封、商丘、太冲、三阴交、交信、太溪、环跳、承山、崑崙、三焦俞、肾俞、气海俞、大肠俞、关元俞、上髂等穴。

（三）颜面神经麻痹亦可灸听会、颊车等穴。

为小儿灸治时，作者建议应用回旋灸法，用一手的拇指、食指与中指持艾卷，使艾卷燃着的一端，在距灸治时所用穴位皮肤约1.5—2厘米高处，不断地缓慢地做小的回旋动作，向左或向右回旋均可。每次灸2—3分钟，至灸治部位皮肤发红为度。

针治小儿麻痹症时，宜根据每个患儿的具体病情，选择适当的穴位。例如：针治患上肢或下肢麻痹的小儿麻痹症患儿时，宜根据上肢或下肢各个关节运动检查的结果，选择适当的穴位：

运动检查结果	发生麻痹的肌肉	针治取穴	针治穴位的神经分布	针治穴位所属经脉
肩不能上举或上举能力减弱	斜方肌	肩井	副神经等	足少阳胆经
手不能平举或平举能力减弱	三角肌	臂臑	腋神经等	手阳明大肠经
		肩髃	来自腋神经之臂外侧皮神经等	手阳明大肠经
		肩贞	腋神经等	手太阳小肠经

手不能高举或 高举能力减弱	斜方肌,前 锯肌	臂 臑 肩 髃 肩 貞 肩 井	腋神經等 来自腋神經之 臂外側皮神經 等 腋神經等 副神經等	手阳明大腸經 手阳明大腸經 手太阳小腸經 足少阳胆經
肘关节不能屈 曲或屈曲能力 减弱	肱二头肌 等	手三里 曲池 尺澤	桡神經等 桡神經等 桡神經等	手阳明大腸經 手阳明大腸經 手太阴肺經
肘关节不能伸 直或伸直能力 减弱	肱三头肌	手三里 曲池	桡神經等 桡神經等	手阳明大腸經 手阳明大腸經
手腕不能屈曲 或屈曲能力减 弱	腕屈肌	間使 内关 灵道 神門	正中神經等 正中神經等 尺神經等 尺神經等	手厥阴心包絡 經 手厥阴心包絡 經 手少阴心經 手少阴心經
手腕不能背曲 或背曲能力减 弱	腕伸肌	合谷 外关 支沟	桡神經 桡神經等 桡神經等	手阳明大腸經 手少阳三焦經 手少阳三焦經
手指不能屈曲 或屈曲能力减 弱	骨間肌与 指屈肌	間使 内关 灵道 神門	正中神經等 正中神經等 尺神經等 尺神經等	手厥阴心包絡 經 手厥阴心包絡 經 手少阴心經 手少阴心經
手指不能伸直 或伸直能力减 弱	指伸肌	合谷 外关 支沟	桡神經 桡神經等 桡神經等	手阳明大腸經 手少阳三焦經 手少阳三焦經

运动检查结果	发生麻痹的肌肉	针治取穴	针治穴位的神经分布	针治穴位所属经脉
手指分开和并拢能力丧失或减弱	骨间肌	灵道门	尺神经等 尺神经等	手少阴心经 手少阴心经
中、末两指节伸直，同时基节屈曲能力丧失或减弱	蚓状肌，骨间肌	间使 内关 灵道门	正中神经等 正中神经等 尺神经等 尺神经等	手厥阴心包络经 手厥阴心包络经 手少阴心经 手少阴心经
髋关节不能前屈(屈腿向腹)或前屈能力减弱	髂腰肌等	伏兔 阴市 梁丘 血箕门	股神经 股神经 股神经 股神经等 股神经等	足阳明胃经 足阳明胃经 足阳明胃经 足太阴脾经 足太阴脾经
髋关节不能后屈或后屈能力减弱	臀大肌	环跳扶	臀下神经等 臀下神经等	足少阳胆经 足太阳膀胱经
大腿不能内收或内收能力减弱	内收肌等	箕门	闭孔神经等	足太阴脾经
大腿不能外展或外展能力减弱	臀小肌	环跳	臀上神经等	足少阳胆经
膝关节不能伸直或伸直能力减弱	股四头肌	伏兔 阴市 梁丘 血箕门	股神经 股神经 股神经 股神经等	足阳明胃经 足阳明胃经 足阳明胃经 足太阴脾经
膝关节不能屈曲或屈曲能力减弱	股二头肌，半腱肌，半膜肌等	承扶 殷门	坐骨神经等 坐骨神经等	足太阳膀胱经 足太阳膀胱经

足不能背屈或背屈能力減弱	脛骨前肌	阳陵泉 光明 阳輔 悬鐘 丘墟 足三里 上巨虛 下巨虛 解谿	腓神經等 腓淺神經等 腓淺神經等 腓淺神經等 腓淺神經 腓深神經等 腓深神經等 腓深神經等 腓淺神經等	足少阳胆經 足少阳胆經 足少阳胆經 足少阳胆經 足少阳胆經 足阳明胃經 足阳明胃經 足阳明胃經 足阳明胃經
足不能跖曲或跖曲能力減弱	小腿三头肌	三阴交 阴陵泉 委中 承山 交信	脛神經等 脛神經等 脛神經等 脛神經等 脛神經等	足太阴脾經 足太阴脾經 足太阳膀胱經 足太阳膀胱經 足少阴腎經
足不能外轉或外轉能力減弱	腓骨肌	阳輔 悬鐘 丘墟 足三里 上巨虛 下巨虛 崑崙	腓淺神經等 腓淺神經等 腓淺神經 腓深神經等 腓深神經等 腓深神經等 腓淺神經等	足少阳胆經 足少阳胆經 足少阳胆經 足阳明胃經 足阳明胃經 足阳明胃經 足太阳膀胱經
足不能內轉或內轉能力減弱	脛骨前肌 脛骨后肌	太谿 交信 三阴交 委中 承山	脛神經等 脛神經等 脛神經等 脛神經等 脛神經等	足少阴腎經 足少阴腎經 足太阴脾經 足太阳膀胱經 足太阳膀胱經

运动检查结果	发生麻痹的肌肉	针治取穴	针治穴位的神经分布	针治穴位所属经脉
足不能伸展或伸展能力减弱	趾伸肌	阳 辅 悬 钟 丘 墟 足三里 上巨虚 下巨虚 解 谿 太 冲 中 封 箕 丘	腓浅神经等 腓浅神经等 腓浅神经等 腓深神经等 腓深神经等 腓深神经等 腓浅神经等 腓深神经 腓浅神经等 腓浅神经等	足少阳胆经 足少阳胆经 足少阳胆经 足阳明胃经 足阳明胃经 足阳明胃经 足阳明胃经 足厥阴肝经 足厥阴肝经 足太阴脾经
足趾不能屈曲或屈曲能力减弱	趾屈肌	三阴交 交 信 委 中 承 山	胫神经等 胫神经等 胫神经等 胫神经等	足太阴脾经 足少阴肾经 足太阳膀胱经 足太阳膀胱经

对于已经发生畸形的小儿麻痹后遗症,则应根据其畸形,选择适当的穴位:

畸 形	发生麻痹的肌肉	针治取穴	针治穴位的神经分布	针治穴位所属经脉
腕下垂 (见图13)	腕伸肌	合 谷 外 关 支 沟	桡神经 桡神经等 桡神经等	手阳明大肠经 手少阳三焦经 手少阳三焦经
膝反屈 (见图14)	股二头肌, 半膜肌, 半腱肌	承 伏 股 门	坐骨神经等 坐骨神经等	足太阳膀胱经 足太阳膀胱经

馬蹄足 (見圖15)	脛骨前肌	陽陵泉 光明 陽輔 懸鐘 丘墟 足三里 上巨虛 下巨虛 解谿	腓神經等 腓淺神經等 腓淺神經等 腓淺神經等 腓淺神經 腓深神經等 腓深神經等 腓深神經等 腓淺神經等	足少陽胆經 足少陽胆經 足少陽胆經 足少陽胆經 足少陽胆經 足陽明胃經 足陽明胃經 足陽明胃經 足陽明胃經
內翻足	腓骨肌	陽輔 懸鐘 丘墟 足三里 上巨虛 下巨虛 崑崙	腓淺神經等 腓淺神經等 腓淺神經 腓深神經等 腓深神經等 腓深神經等 腓淺神經等	足少陽胆經 足少陽胆經 足少陽胆經 足陽明胃經 足陽明胃經 足陽明胃經 足太陽膀胱經
外翻足 (見圖16)	脛骨前肌 脛骨后肌	太谿 三陰交 委中 承山	脛神經等 脛神經等 脛神經等 脛神經等 脛神經等	足少陰腎經 足少陰腎經 足太陰脾經 足太陽膀胱經 足太陽膀胱經
仰趾足	小腿三頭肌	三陰交 陰陵泉 委中 承山 交信	脛神經等 脛神經等 脛神經等 脛神經等 脛神經等	足太陰脾經 足太陰脾經 足太陽膀胱經 足太陽膀胱經 足少陰腎經



图 13 颌下垂

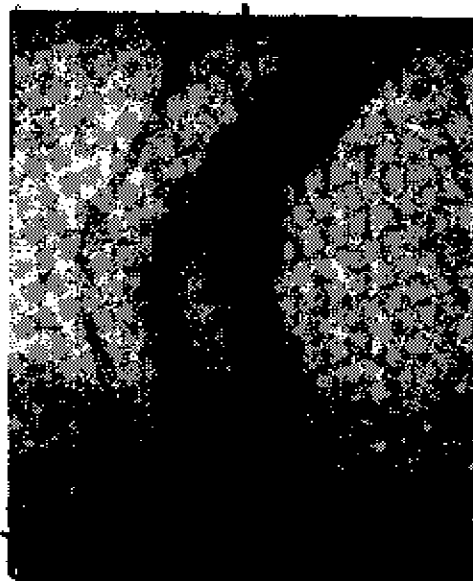


图 14 膝反屈

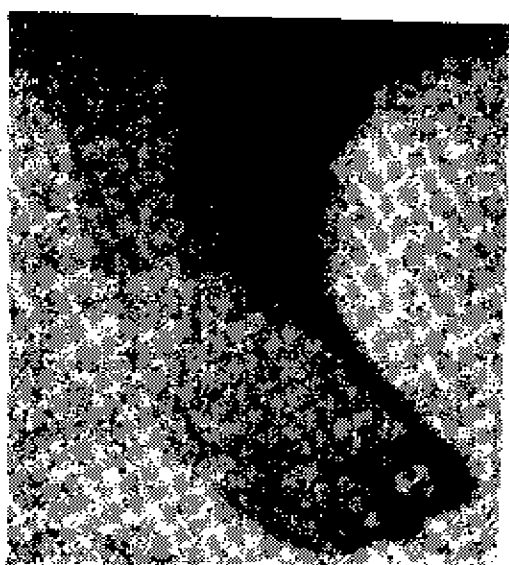


图 15 马蹄内翻足



图 16 外翻仰趾足

針治上、下肢麻痺及其后遺症時，除應根據上肢及下肢運動檢查結果或根據其已發生的畸形，適當的選擇上述各穴外，並可根據被侵犯的脊髓節段，適當的選取下列各穴：

（一）上肢麻痺的發生，主要是因為病毒侵犯了脊髓Ⅴ—Ⅵ頸節的前角，故宜針刺大椎、陶道或椎旁等穴。

●（二）下肢麻痺的發生，主要是因為病毒侵犯了脊髓Ⅲ—Ⅴ腰節或Ⅰ—Ⅲ骶節的前角，故宜針刺三焦俞、腎俞、氣海俞、大腸俞、關元俞或上髎等穴。

針治顏面神經麻痺時，宜選擇有顏面神經分布的下列經穴：

（一）手陽明大腸經經穴：迎香等。

（二）足陽明胃經經穴：四白、地倉、顴車、下關等。

（三）手少陽三焦經經穴：翳風、絲竹空等。

（四）足少陽膽經經穴：瞳子髎、听會、陽白等。

（五）督脈經穴：人中等。

針治時，對一般患兒僅針刺麻痺側的經穴即可能治好；對特別頑固的病例，亦可採用健側與麻痺側經穴均針刺的方法；但宜遵循“先針健側，後針患側”的原則。

針治顏面神經麻痺時，除應適當地選取有顏面神經分布的局部穴外，亦應配合以合谷或列缺等遠隔穴。

二、顏面神經麻痺

病因：顏面神經麻痺即祖國醫學的書籍中所稱的“口眼喎斜”。

顏面神經麻痺的原因很多：有些人認為局部受寒是發生顏面神經麻痺最普通的原因。很多病例的顏面神經麻痺乃系因感染所引起，例如：腮腺發生炎症時，面神經亦可能被波

及，引起面神經麻痺；流行性乙型腦炎或其他腦炎及中耳炎亦可併發面神經癱。外傷亦可能引起面神經麻痺。

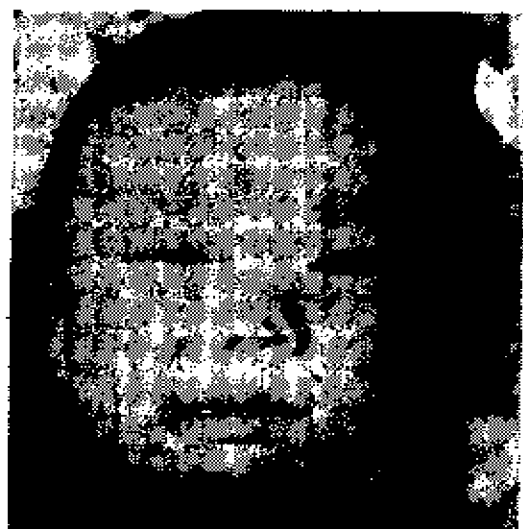
症狀：面神經麻痺通常限於一側，雙側顏面神經麻痺非常少見。伯耳氏癱瘓是顏面神經麻痺最常見的一種。

主要症候是口向健側歪斜，因健側面肌牽引所致。哭或笑時嘴歪更加顯著，口角下垂。患側鼻唇溝消失或變淺。患者因口唇輪匝肌麻痺，不能作吹口哨動作。因患側口角漏氣，故也不能鼓頰。因頰肌麻痺，故咀嚼時食物常存於患側之齒齦與面頰之間。患者常流涎，飲水時常自口角流出，乃因口輪匝肌機能不全之故，唇音發音不清，作露齒動作時，患側口角不能向外展。周圍性面神經麻痺，除有上列症狀外，尚有患側眼瞼不能閉合或不能閉緊；患側眼裂變大及患側之前額不能作皺紋等病征。當企圖閉眼時，可從患側眼裂看見患側眼球向上方和外側轉動，即所謂 Charles Bell 氏征。患側眼裂變大，眼瞼不能閉合或不能閉緊乃因眼輪匝肌麻痺所致。由動眼神經所支配之上瞼提肌獨自活動，失去眼輪匝肌的拮抗作用的原故。周圍性面神經麻痺患兒亦常有患側眼睛時常流淚等現象。中樞性面神經麻痺患者則僅發生口向健側歪斜，不能作吹口哨動作及不能鼓頰等現象；並無上述患側眼瞼不能閉合與不能皺額等病征。

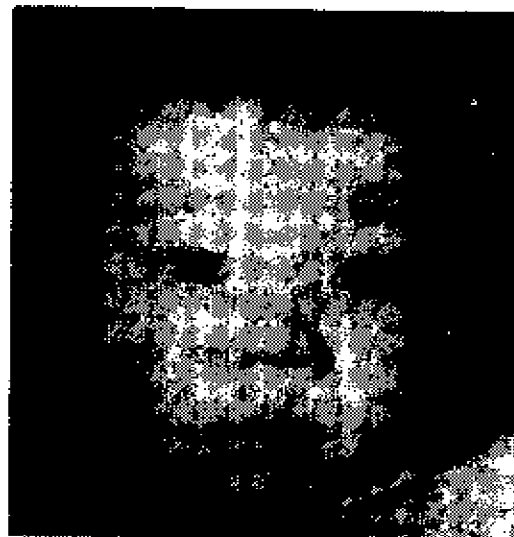
針灸療法：針灸療法有促進顏面神經麻痺恢復的作用。一般患兒經過數次或十幾次之針灸治療後即可能痊癒、近愈或顯著好轉。

病例：患兒李××，男，3歲5個月，門診號58279，於1953年11月11日初診時，主訴為嘴向右歪已6天。診查時見患兒顏面失去對稱，嘴顯著向右歪，哭或笑時嘴歪更加顯著；左鼻唇溝消失；左眼不能閉合。診斷：左側顏面神經麻

痹。針刺患側絲竹空、瞳子髎、听会、地仓、頰車及下关一次后，嘴歪即見減輕，左眼亦稍能閉合。針治4次后，嘴已不歪，哭或笑時亦已不歪，左眼已能閉緊，左鼻唇溝不但已出現而且已經恢復正常，結果痊愈。



針灸治療前



針灸治療后

图 17 顏面神經麻痺

顏面神經麻痺系属于“虛症”，故应根据“虛則补之，實則瀉之”的原則，給予“补”的手法。作者針治小兒顏面神經麻痺時所用的手法是：捻轉進針，待“氣至”后，再微捻數下，給予短時間的弱刺激，用“补”的手法，达到兴奋顏面神經促進其麻痺恢復的作用后，即刻捻轉退針，針刺的方向一般均采用直針。对于严重的病例，于針刺地仓穴時，針刺的方向亦可采用橫針，向着頰車方向平刺。

針治小兒顏面神經麻痺時，作者最常应用的經穴是：

- (一) 足陽明胃經經穴：地仓、頰車、下关。
- (二) 手少陽三焦經經穴：翳風、絲竹空。

(三) 足少阳胆經經穴：瞳子髎、听会。

針治小儿顏面神經麻痺时，作者除应用顏面部有顏面神經分布的經穴外，并常配合手上的合谷穴，有时亦配合上肢的列缺。除上述各穴外，手阳明大腸經的迎香，足阳明胃經的四白，足少阳胆經的阳白及督脉的人中等經穴亦有时采用。除針治外，亦可配合灸治作为輔助疗法，用回旋灸法灸患側的地仓、頰車与听会；每次灸2—3分鐘。

作者于針治小儿顏面神經麻痺的实践中，观察到因“风寒侵袭”所致的“受寒性”面神經麻痺，經針治数次或十几次后即可能痊愈或近愈。对于脊髓灰質炎(小儿麻痺症)病毒所引起的面神經麻痺效果也很好，但需治疗較长时期：患儿經2—3个月的治疗后即可能痊愈、近愈或显著好轉。“外伤性”面神經麻痺，其疗效与其受伤的严重程度有密切关系，若受伤不太重，有希望于針治較长时期后恢复痊愈、近愈或显著好轉；若受伤过重，則难以完全恢复，但仍有可能于針治較长时期后好轉或显著好轉。針灸治疗末梢性面神經麻痺，效果好而且快；对于中枢性面神經麻痺，效果不太明显，且需治疗較长时期。脑炎后遗症患儿的面神經麻痺，需治疗2—3个月或更久，可能痊愈、近愈或显著好轉。針灸治疗面神經麻痺，如能及时針治而且能遵照医嘱坚持繼續針灸治疗者效果效好；若麻痺已数月，甚至数年才开始針灸治疗的，效果远不如早期針治者为佳。

三、小兒夜驚症

病因：小儿夜惊症多由于受了惊吓，受了精神刺激，或因就寝前过度飽食，发生消化不良等胃腸障碍，或因膀胱充盈，或因腸寄生虫，或因鼻部腺增殖等引起。小儿夜惊症多发现

于2—8岁小儿，尤以3—6岁身体虚弱神经容易受刺激的神经质小儿最为常见。

症状：患儿于入睡1—3小时后，突然惊醒号叫啼哭，呈现惊惧恐怖状。每次发作约15—20分钟后，心神始安定，而再入睡。或每夜发作一次，或每夜反复发作数次，或隔数日或十几日发作一次。

针灸疗法：患儿经针灸治疗后可能迅速痊愈。

病例：患儿王××，女，7岁，门诊号47756。于1956年12月30日来院诊疗时，诉20多天来时常于夜里入睡后约3小时左右（夜里12点左右）突然号叫啼哭，似做恶梦惊惧恐怖状。每次发作持续约15分钟左右，心神始安定，而再入睡。印象：夜惊症。经灸百会一次（应用回旋灸法灸4分钟）后，即迅速痊愈。

应用回旋灸法灸督脉的百会穴即可能治好小儿夜惊症，每次可以灸3—5分钟。除灸百会穴外，亦可针治，针治时可取下列各穴：

- （一）经外奇穴中的十宣穴。
- （二）手太阴肺经井穴：少商。
- （三）手阳明大肠经原穴：合谷。
- （四）手少阴心经俞穴：神门。
- （五）足少阴肾经井穴：涌泉。
- （六）督脉经穴：大椎、人中等。

针治的手法，在进针后，再捻转约15—30秒钟后，即退针。

四、小兒驚厥

惊厥系小儿常见症状之一，尤以新生儿及婴幼儿更容易

发生惊厥，原因是新生儿及婴幼儿大脑皮质尚未发育成熟，故当新生儿或婴幼儿受到强烈刺激时，容易发生惊厥。小儿惊厥即祖国医学书籍中所称的小儿“惊风”。

原因：发生惊厥的原因很多，下列各病症均可能发生惊厥：

(一) 中枢神经系统病变：1. 颅内出血。2. 大脑发育不全、头小畸形等。3. 脑积水。4. 化脓性脑膜炎；包括流行性脑脊髓膜炎等。5. 结核性脑膜炎。6. 浆液性脑膜炎。7. 流行性乙型脑炎。8. 继发性，或合并传染病性脑炎（麻疹、水痘、流行性腮腺炎及流行性感冒等很多种传染病均可能并发脑炎）。9. 瘦咬病（狂犬病）。10. 破伤风。11. 脑水肿（急性肾炎的脑症状，即所谓“假性尿毒症”；番木鳖素中毒；酒精中毒；水杨酸中毒；铅中毒等）。12. 脑肿瘤。13. 脑脓肿。14. 脑囊肿。

(二) 虚性脑膜炎：急性咽炎、支气管炎、大叶性肺炎、杆菌痢疾、肾盂炎、疟疾、天花、猩红热、伤寒、新生儿败血症等都可能并发虚性脑膜炎，发生惊厥。

(三) 手足搐搦症。

(四) 血糖过低症。

(五) 乙₁种维生素缺乏症。

(六) 尿毒症。

(七) 瘧病。

(八) 癲癇。

症状：祖国医学书籍中有“惊风八候”的记载。所谓“惊风八候”即“搐”“搦”“掣”“颤”“反”“引”“窜”“视”系以八个字代表“惊风”时的症候。“搐”的意思是肘臂伸缩。“搦”的意思是十指开合。“掣”的意思是肩头相扑。“颤”的意思是手足动摇。“反”的意思是身仰向后，也就是角弓反张的意思。

“引”的意思是手若开弓。“窜”的意思是目直视而似怒。“视”的意思是睛露而不活。

⑤ 患儿于惊厥时，神志可能消失，一侧或双侧面部及四肢肌肉有强直性或阵挛性痉挛。若痉挛时间过长，则有大量出汗与体温上升等现象。惊厥时，患儿眼球上转或固定，并能发现大小便失禁、皮肤发紺、呼吸节律不整、脉数（脉搏加速）等现象。

诊断：惊厥的原因繁多，预后也各不相同，治疗时必需要确定诊断，根据病原，加以适当之治疗；故惊厥患儿的诊断非常重要。诊断时，宜注意下列各点：

（一）病历：

1. 患儿有无发热：患儿若有发热，宜考虑是否流行性脑脊髓膜炎等化脓性脑膜炎、结核性脑膜炎、浆液性脑膜炎、流行性乙型脑炎、继发性或合并传染病性脑炎、急性咽炎或肺炎等急性热病所引起之虚性脑膜炎、破伤风、急性肾炎或脑脓肿等。患儿若无发热，宜考虑是否颅内出血、番木鳖素中毒、铅中毒、脑肿瘤、手足搐搦症、血糖过低症、婴儿脑型脚气病、尿毒症或癫痫等。

2. 患儿神志是否消失：患儿神志若不清，宜考虑是否颅内出血、脑积水、流行性脑脊髓膜炎等化脓性脑膜炎、结核性脑膜炎、浆液性脑膜炎、流行性乙型脑炎、继发性或合并传染病性脑炎、脑肿瘤、脑脓肿、急性咽炎等所引起之虚性脑膜炎，手足搐搦症，尿毒症，瘧病或癫痫等。患儿神志若未消失，宜考虑是否破伤风或番木鳖素中毒等。

3. 患儿年龄：一月内之新生儿若发生惊厥，宜考虑是否患颅内出血、破伤风、化脓性脑膜炎、新生儿败血症或手足搐搦症所致。2至6月之婴儿若发生惊厥，则宜多考虑手足

搐搦症、各种脑膜炎、虚性脑膜炎、乙种维生素缺乏症及大脑发育不全等所引起。7月至两岁之婴幼儿若发生惊厥，宜考虑是否因手足搐搦症、各种脑膜炎或虚性脑膜炎所致。两岁以上之小儿若发生惊厥，宜考虑是否因虚性脑膜炎、各种脑膜炎、脑炎、急性肾炎或癫痫所引起。

(二) 检查：1. 身体检查。2. 脑脊髓液之检查。3. 血液化学之检查：检查钙、磷、糖及非蛋白氮等之检查。4. 血液细菌培养。5. 大便检查。6. 小便检查。

针灸疗法：针灸对于小儿颅内出血、流行性乙型脑炎、继发性或合并传染病性脑炎及瘧病(希斯忒利亚)等所引起之惊厥，可能起到镇静作用，故均可试用针灸治疗。手足搐搦症患儿应以肌肉注射葡萄糖酸钙及口服氯化钙等治疗，但亦可应用针灸作为辅助疗法；血糖过低症患儿应静脉注射葡萄糖，但对兼见者可试用针灸作为辅助疗法；婴儿脑型脚气病，宜口服及皮下注射或肌肉注射乙种维生素，并可应用针灸作为辅助疗法；急性肾炎的脑症状，应以硫酸镁治疗，亦可试用针灸辅助；番木鳖素中毒、酒精中毒、水杨酸中毒及铅中毒之患儿，应积极治疗其中毒；流行性脑脊髓膜炎等化脓性脑膜炎患儿，应用磺胺及青霉素等药物治疗；流行性感冒杆菌脑膜炎，应用磺胺及链霉素治疗；结核性脑膜炎，应以链霉素及雷米封(异菸肼)等治疗；急性咽炎及肺炎等急性热病所引起之虚性脑膜炎，虽亦可试用针灸治疗；但仍应根据病历及诊查结果，确定诊断，根据病原，给予适当之药物治疗；例如：肺炎应以磺胺及青霉素等药物为主要治疗；破伤风应以破伤风抗毒素等为主要治疗。

头小畸形等大脑发育不全、脑积水、癫痫、脑肿瘤、脑脓肿及脑囊肿等症，均不适宜应用针灸治疗。

对于癫痫一症，至今尚无特效疗法，可試用針灸治疗。癫痫患儿經长期針灸治疗后可能有进步或显著好轉，发作次数减少，发作時間縮短，症状減輕。少数患儿經針灸治疗后可能有痊愈之希望。

病例：患儿姜××，男，3岁半，門診号34590。于1956年4月3日入院針灸科初診，主訴：五个月以来时常抽风。抽时兩眼球上翻、顏面及四肢抽动、人事不省、持續約10余分钟。抽后疲倦嗜睡，睡約1—2小时，醒后一切正常。此后約每隔半月左右即抽风一次。自1956年2月20日后，抽风加重：每天抽2—3次，并有一次抽风时小便失禁。曾用魯米那(Luminal)等鎮靜药治疗，但仍有抽风。自3月28日开始每日抽风5—6次之多。自发病以后食欲差、脾气不好、智力发育受障碍、記憶力減退。檢查：营养中等、神志清、頸軟、克匿格氏征阴性、巴彬斯奇氏征阴性。印象：癫痫。針灸治疗后很見效；自开始針治一次后，即連續7个多月未抽风；但于1956年11月7日又抽风一次，持續2—3分钟，不严重。經繼續針灸治疗后，至今有一年半之久，一直未发，食欲轉好、智力与記憶力亦均好轉。針治取穴：合谷、少商、商阳。

針治小儿惊厥，采用的穴位是：

(一) 十二井穴，即手太阴肺經之少商、手阳明大腸經之商阳、手厥阴心包絡經之中冲、手少阳三焦經之关冲、手少阴心經之少冲及手太阳小腸經之少澤。

(二) 十宣穴。

(三) 手阳明大腸經之原穴，合谷。

下列各穴，亦有时采用：

(一) 手少阴心經之俞穴：神門。

(二) 手厥阴心包絡經之經穴：間使。

(三) 足少阳胆經之合穴：阳陵泉。

(四) 足太阴脾經之井穴：隱白。

(五) 足少阴腎經之井穴：涌泉。

(六) 足少阳胆經：风池穴。

(七) 督脉：身柱、大椎、百会及人中等穴。

(八) 經外奇穴：印堂等。

針治的手法：进針后，捻轉約 15—30 秒鐘，然后退針。針刺十二井或十宣穴后，若放出少量之血，則更为有效。

五、休 克

病因：由于創伤、出血、燒伤、燙伤、脫水、严重的感染、剧痛、精神刺激或手术等原因所致。飢餓、疲勞、失眠、貧血、寒冷等时常是休克的誘因。休克发生的机制是由于机体的感受器接受体内外的刺激，由傳入神經傳導至大腦皮質，在大腦皮質形成兴奋灶。由于負誘導，兴奋灶的周圍引起抑制。若不断地繼續有刺激冲動傳入大腦皮質，則可能引起超限抑制，引起大腦皮質細胞的疲乏与衰竭，以致失去大腦皮質对于皮質下中樞的調节作用，使血管运动中樞及呼吸中樞等皮質下中樞的机能发生紊乱，使全身主要脏器的机能失常，因而发生休克。

症狀：面色蒼白、皮肤发冷、出冷汗、血压下降、脉搏細、快而微弱，甚至于腕部(寸口)难以触知或不能触知，呼吸快，体溫有时下降 1—2°C。患者对周圍环境沒有兴趣；呈迟鈍、淡漠及非常軟弱状，回答問題时非常緩慢。严重休克的患者似入失去知觉状态，若不及时急救，可能迅速死亡。

針灸療法：針灸療法对休克有良好療效。

病例：患儿刘××，六岁，男，門診号：73487，于 1954 年

7月29日突然昏倒，急送入院，診查時，見患兒面色蒼白、神志不清、皮膚冷而濕，脈搏細弱而快。診斷為休克。經用針灸療法急救，指針人中穴後，患兒神志即清醒，迅速恢復健康。

治療休克時，常用的針灸療法：

(1) 指針人中穴。

(2) 用速刺法或捻轉法針刺人中、少商或十宣穴。

對於休克患兒除應用指針或速刺法急救外，並宜使患兒取臥位，頭低腳高，保持適當溫度，過熱能使休克加重。對非常嚴重的休克患兒，除針治外，亦可皮下注射安息香酸鈉咖啡因或可拉明等，作為輔助治療。

六、小兒失語症

失語症是言語障礙之一，由於大腦皮質的病變所產生的言語、文字的認識或表達失常，而受納和表達言語的感覺運動器官並未損害的一種言語障礙。

原因：失語症乃因大腦皮質的言語高級機構“言語中樞”因患腦炎、顱腦損傷、腦出血、腦栓塞、腦腫瘤或腦膿腫等病所致。“言語中樞”位於大腦皮質內，習慣用右手的人的“言語中樞”位於左側大腦半球內；習慣用左手的人的“言語中樞”則位於右側大腦半球內。“運動性言語中樞”受損害時，發生運動性失語症；“感覺性言語中樞”受損害時則發生感覺性失語症。

症狀：

(一) 運動性失語症：患兒喪失說話的能力，不能用言語表達。患兒雖然尚能理解言語（因感覺性言語中樞尚未遭受損害）但說不出來。較輕的患兒雖然尚能說比較簡單的話，但說話慢而困難，發音不清，說話時常斷斷續續。

(二) 感觉性失語症：患儿听觉虽无障碍，但不了解言語的意义，沒有听懂別人講話的能力。

針灸療法：在針灸治療小兒失語症的實踐中，体会到針灸療法對於患流行性乙型腦炎、麻疹後腦炎、流行性腮腺炎并發之腦炎及顱內出血所發生的失語症是有效的。患兒經針灸治療後可能痊愈、近愈或顯著好轉。但針灸對於患腦腫瘤等病而發生的失語症則不能治好。

針治小兒失語症，常用的穴位：

(一) 瘡門：針刺時，宜特別小心，僅能針刺2—3分深（中指同身），不應深刺。針治時，必需助手協助固定患兒頭部、軀干與四肢，以免患兒于針治時突然亂動，以致于針刺過深，發生危險。針刺前，必需先用碘酒再用酒精認真消毒針刺部位之皮膚。

(二) 合谷。

(三) 涌泉。

針治手法：進針後，捻轉10—20秒鐘，即行退針。

病例：患兒桃萍，2歲4個月，女，門診號49769。于1955年10月8日來我院初診時，主訴為喪失說話的能力，已將近一個半月。患兒于1955年8月27日突發高燒，曾在某醫院住院診療，診斷為流行性乙型腦炎。經治療後，燒退，神志恢復，但不会說話，嚴重到連一個字也不会說了，而且不会走路。介紹來我院針灸治療其後遺症。檢查：營養尚佳，神志清楚，但不会說話，頸軟，兩下肢有痙攣性麻痺，兩側膝反射亢進，不会走路，克匿格氏征陰性。印象：流行性乙型腦炎後遺症（失語症并發兩下肢癱瘓）。經針治3次後，即能走幾步了。針治5次後，會叫“媽媽”“姐姐”“奶奶”，走路亦較穩。針治6次後，會叫“爸爸”“姨”了，能走很快很遠，而且能跑。針治

17次后，能說許多話。針治25次后，說話能力已完全恢復，而且說得很清楚，並且會唱歌，兩下肢亦已完全恢復正常。結果痊愈。

針灸取穴：(1)瘡門、合谷、涌泉。(2)風市、陽陵泉、足三里、三陰交、大腸俞。

七、小兒腦炎后遺症

小兒腦炎有很多種。由特异性濾過性病毒所引起的流行性乙型腦炎是常見的一種。由濾過性病毒所致的麻疹、水痘、流行性感冒及流行性腮腺炎等傳染病均可能并发腦炎。細菌所致之痢疾亦有時并发腦炎。

症狀：流行性乙型腦炎的發病大多數是急驟的，患兒突發高熱，并有嘔吐、頭痛、抽風及嗜睡等症狀。常見的體征有頸強直，嬰兒則有時可見前囟凸出。或見神志不清、克匿格氏征陽性、布魯辛斯克氏征陽性及巴彬斯奇氏征陽性等體征。此外，可能發生偏癱、面癱及失語等后遺症。

麻疹后腦炎為麻疹的并發症。在麻疹的皮疹出現后第3—5日，當發燒已退的時候，忽然又發高熱，并有嗜睡甚至昏迷等現象。此外，并常出現惊厥，并可發生偏癱或單癱、面神經麻痺、失明、癲癇樣發作、智力減退，甚至成為痴呆等后遺症。

水痘有時亦可能并发腦炎，但很少見。大都在皮疹發作時出現體溫增高、惊厥、意識障礙、語言障礙、顏面神經麻痺及偏癱等症。

流行性感冒亦可能并发腦炎，出現惊厥、昏迷、頸強直等神經系症狀，亦可能發生偏癱、顏面神經麻痺及言語障礙等后遺症。

流行性腮腺炎所并发之脑炎，发生于腮腺肿胀的前后或同时发生。少数病例亦有单独出现脑炎而不出现腮腺肿胀症状。主要症状为发烧、头痛、呕吐、惊厥、昏迷及颈强直等症状。并可发生偏瘫、失语症、耳聋及智力减退等后遗症。

杆菌痢疾患儿亦可能并发脑炎，有发热、惊厥、昏睡、谵妄、颈强直等症，并可能发生偏瘫等后遗症。

针灸疗法：针灸疗法有促进与帮助脑炎后遗症恢复的作用。因患流行性乙型脑炎、麻疹后脑炎、流行性感冒并发脑炎、流行性腮腺炎并发脑炎及杆菌痢疾并发之脑炎而发生之面神经麻痹、偏瘫、单瘫、失语症及耳聋等后遗症经用针灸治疗后可能痊愈、近愈、显著好转或好转。早期即用针灸治疗，效果较好。

针治取穴：

(1) 针治颜面神经麻痹取穴：丝竹空、瞳子髎、地仓、颊车、下关、听会、翳风、合谷等。

(2) 针治上肢麻痹取穴：肩髃、肩贞、肩井、臂臑、曲池、手三里、支沟、外关、间使、内关、灵道、神门、合谷、大椎与椎旁等。作者最常应用之穴位为肩髃、肩井、曲池、支沟、合谷与大椎。

(3) 针治下肢麻痹取穴：伏兔、阴市、梁丘、血海、阴陵泉、阳陵泉、足三里、上巨虚、阳辅、悬钟、丘墟、解谿、商丘、环跳、承扶、殷门、委中、承山、崑崙、太溪、交信、三阴交、三焦俞、肾俞、气海俞及大肠俞等。作者最常应用之穴位为梁丘、血海、阳陵泉、足三里、阳辅、三阴交、委中、殷门、肾俞及大肠俞。

(4) 针治失语症取穴：哑门、合谷、涌泉等。

(5) 针治耳聋取穴：主要采用任伊尊氏针治耳聋时所常用之耳门、听宫、听会、翳风及合谷等穴。

針治手法：

(一) 針治顏面神經麻痺、偏癱或單癱的手法是捻轉進針后，待“氣至”再捻轉數下，即行退針。

(二) 針治失語症或耳聾的手法是：進針后，捻轉10—20秒鐘，即行退針。

病例：患儿張××，3岁，女。于1956年10月23日初診，主訴：右側偏癱，不会說話，已廿余日。发病初期，高烧昏迷4天后，即发现右側上下肢不会動轉，而且不会說話。未发生昏迷前，曾腹瀉，每天約4—5次以上，內含膿血，高烧時曾抽風。檢查：營養中等，神志清，但不会說話，頸軟，右側上下肢偏癱，呈強直性麻痺，右側二頭肌反射亢進，右側三頭肌反射(+)右手不能持物，右臂不能高舉，右膝反射亢進，右腳呈下垂狀攣縮，甚強直，以致不能將腳放平，不会走路。巴彬斯奇氏征右側陽性，克匿格氏征(+)。印象：中毒性腦炎后遺症(痢疾所引起的)。針治5次后，会叫“爸爸”“媽媽”“奶奶”“伯伯”“哥哥”“姨”。右手已会拿东西，并能走几步。針治22次后，右臂已能高舉，右手能持物，也很有力，右側上下肢，動作自如，能走很快很远很穩，而且会跑，說話能力亦已完全恢复，亦很清楚。結果痊愈。

針治取穴：

(一) 針肩井、肩髃、曲池、支溝、大椎。

(二) 針風市、梁丘、陽陵泉、足三里、三陰交、大腸俞。

(三) 針瘰癧門、涌泉、合谷。

八、小舞蹈症

小舞蹈症是舞蹈症中最常見的一種，也叫做辛德汉(Sydenham)氏舞蹈症，系風濕病的表現之一，所以也叫做風

濕性舞蹈症。費拉托夫(Н. Ф. Филатов)氏認為舞蹈病是一種風濕性腦病，多見於5—15歲的小兒，女較男為多。

症狀：小舞蹈病的主要症狀為舞蹈動作，患兒發生不自主的肢體舞動，並出現一種極快的不隨意運動。例如：蹙額、顰眉、眨眼、咧嘴、吐舌、聳肩、軀體扭轉、手舞、足蹈等動作。症狀大都在清醒時顯出，入睡後全部停止。在舞蹈症嚴重的病例，患兒坐不穩，站立走路均不能，不能獨自進食或穿衣，且可能發生言語含糊不清。檢查時可發現肌張力的減低。小舞蹈症往往與風濕性關節炎或風濕性心臟病合併發生。

針灸療法：針灸療法有促進小舞蹈症恢復的作用，值得廣泛試用。

針治取穴：風池、天柱、大椎、身柱、肩髃、曲池、手三里、支溝、合谷、神門、風市、陽陵泉、足三里、三陰交。

針治手法：進針後，待“氣至”再捻轉約15—30秒鐘，即行退針。或於進針後，留針5—10分鐘。

病例：患兒任××，九歲，男，門診號63303。於1954年2月來我院初診，主訴：一個月來右側上下肢不隨意地舞動。右手已不會拿東西，不能穿衣寫字、獨自進食。走路也發生困難。來院初診時，望診見患兒右側上下肢有突發的不隨意運動，肢體的舞動既無一定的方式，亦無一定的節律。切診時發現患兒心臟稍擴大，聽診時於心尖部聽到吹風樣收縮期雜音。血沉檢查：第一小時為26毫米，二小時為60毫米。根據病史及診查結果，診斷為小舞蹈症。經針治兩次後，患兒右側上下肢不自主運動顯著減輕。針治5次後，右手即能使筷子獨自進食，走路亦見顯著好轉。針治9次後，即能寫字。針治12次後，右側上下肢已完全恢復正常。共針治14次，結果痊愈。

九、小兒风湿性关节炎

风湿性关节炎系风湿病的典型表现之一，时常与风湿性心脏病或小舞蹈症合并发生。

病因：风湿病的病原，尚未完全确定。有一些学者认为风湿病是一种传染病，病原体为一种变种的鏈球菌。扁桃体、鼻咽部常为其侵入門戶；故常由于咽峡炎而发病。风湿病病原的最普通的理論是傳染——变态反应学說。根据这个学說，认为风湿病的主要原因是机体对于鏈球菌及其产物的变态反应的结果。由于細菌蛋白或蛋白分解产物侵入机体而产生机体的敏感性，在敏感性的基础上鏈球菌即可能引起风湿病的征状。遺傳、严寒、湿冷及既往曾患猩紅热等传染病均可能成为风湿病的素因。

症狀：风湿性关节炎的主要症状为关节疼痛。最常受侵犯者为膝关节，其次为肘关节、肩关节、腕关节、髋关节及踝关节。患部肿胀、潮紅，触摸时有灼热感，并有压痛。疼痛与肿胀时常由甲关节移至乙关节，即所謂“游走性多发性关节炎”的特征。脊柱也可能受侵犯，特别是脊柱的頸部。患儿除有关节肿胀疼痛症状外，兼有發燒等症状，且可能因关节疼痛而影响睡眠。

針灸療法：針灸疗法是治疗风湿性关节炎很好的一种疗法。患儿經針治数次或十数次，即可痊愈、近愈或显著好轉。

針治取穴：針治小儿风湿性关节炎时，可在发病关节附近取穴，例如：

（一）針治风湿性膝关节炎时，可取风市、梁丘、阳陵泉、足三里及委中等。

（二）針治风湿性肘关节炎时，可取曲池或手三里等穴。

(三) 針治肩关节炎时,可取肩髃、肩井、肩髃等。

(四) 針治风湿性腕关节炎时,可取內关、外关、神門等。

(五) 針治髌关节炎时,可取环跳穴等。

(六) 針治踝关节炎时,可取崑崙、解谿等。

針治手法: 进針后,捻轉約15秒至半分鐘,即行退針。
或于进針后,留針5—10分鐘。

病例: 患儿曹××, 11岁,男,門診号32317。于1954年5月来我院初診,主訴: 左膝关节疼痛已5天。疼痛剧烈,不能走路,已数夜未能安睡。診查时見患儿左膝关节紅肿、发热、压痛均甚明显。診断为风湿性关节炎。針刺风市及阳陵泉一次后,即显著好轉,关节疼痛迅速消失,当夜即能安眠,次晨能独自行走,局部潮紅、发热与压痛均已消失,肿脹亦已显著好轉。針治兩次后,关节肿脹完全消退,結果痊愈。

十、急、慢性胃炎及胃、十二指腸潰瘍

急性胃炎系年长儿的胃障碍(嘔吐、疼痛)疾病。慢性胃炎多由急性胃炎轉变而成。胃与十二指腸均可能发生潰瘍,而成为潰瘍病。潰瘍症在小儿比較少見。急性胃炎、慢性胃炎、胃与十二指腸潰瘍均适合应用針灸治疗,而且治疗方法相同,故在一起介紹。

病因: 急性胃炎的病原有摄食性或傳染性二种。摄食性急性胃炎常見的原因是过食水果、蔬菜、糖食,或吃未成熟的水果,质量低劣的食物,引起胃的机能失調;傳染性急性胃炎,因吃腐敗的食物或陈旧的罐头等;傳染物随着食物侵入而发生的。如急性胃炎持續日久或經治未愈,可轉成慢性胃炎。

关于胃与十二指腸潰瘍的原因有很多学說。根据貝柯夫氏大腦皮質与內脏相关的发病学說,认为潰瘍病的发生乃因

机体的内在和外在环境的刺激相结合所致。病变的起源是在神经系统的高级中枢，至于植物神经系统与内分泌体液机制的失调是继发性的。溃疡病乃因大脑皮质功能障碍所致。

症状：急性胃炎的症状是上腹部（胃区）突然疼痛、恶心及呕吐，呕吐时常是剧烈的。望诊时可見到舌苔很厚，切诊时脉象数（脉快）。

慢性胃炎可分为胃酸过多型及胃酸过少型两种。胃酸过多型慢性胃炎的患者，腹上部（胃区）有持续性疼痛，出现酸性嗝气、胃感灼热、呕吐、食欲无改变，胃液检查时可发现胃液酸度增高，含粘液很多。X线检查，胃粘膜皱襞增大与变厚。在胃酸过少型慢性胃炎的患者，感觉腹上部（胃区）不适，并有压迫感，出现臭的嗝气与恶心，偶有呕吐。食欲不振，胃液检查可发现胃液的总酸减低，没有游离盐酸。X线检查可发现胃皱襞数减少与皱襞变薄。

胃与十二指肠溃疡的主要症状为腹上部疼痛，在年长儿的腹部疼痛比较典型，疼痛部位系在胃或十二指肠部。胃溃疡患者，腹上部疼痛大都在进食后半小时至一小时半，持续约1—2小时逐渐消失。十二指肠溃疡患者，腹上部疼痛大都在餐后2—4小时，持续至再进食时始消失，并常于半夜发生腹上部疼痛，疼痛的性质不一致，有的感觉腹上部胀痛、膨胀、钝痛、灼痛或剧烈疼痛。溃疡病患儿可能发生呕吐或大便黑等症。多数病例胃液酸度增高，少数病例胃液酸度正常或减低。有些病例大便检查显示大便匿血，试验阳性，对诊断很有帮助。X射线钡餐胃肠检查能发现溃疡龛等，对诊断更有帮助。

针灸疗法：针灸疗法对于急性胃炎确有疗效。

针治取穴：足三里（双）、内关（双）、中脘、胃俞（双）。

病例：患儿赵××，13岁，男，門診号49439。于1955年5月24日中午12点多鐘突然发生上腹部(胃区)疼痛，因疼痛非常剧烈，乃来我院急診。患儿除有剧烈腹痛外，嘔吐亦甚严重，自发病后已嘔吐4次，嘔吐黄水粘液，及尚未消化之食物。診查时，見患儿呈現腹部剧烈疼痛状，双手撫捫于上腹部，在診查台上翻滚，高喊肚子疼。腹部触診时发现上腹部(胃区)有压痛，腹部其他部位并无压痛，腹部柔軟，未触及肿块，舌苔厚，脉象“数”。診斷：急性胃炎。針刺足三里穴后，立即痛止而愈。

針灸对于慢性胃炎及胃与十二指腸潰瘍病均有疗效，但需治疗較长时期，并非一次或数次針灸即可治愈。若繼續治疗須数月之久，可能痊愈、近愈或显著好轉。

作者于針治急性胃炎、慢性胃炎、胃与十二指腸潰瘍等胃病时也常采用足三里及中脘为主治穴。按足三里属于足阳明胃經，乃足阳明胃經之合穴，中脘乃胃之募穴，故足三里与中脘为治疗胃病之要穴。

針治急性胃炎、慢性胃炎、胃与十二指腸潰瘍，除应用足三里与中脘外，若再配合以胃俞穴，則更加有效。按胃俞乃胃之俞穴，中脘乃胃之募穴，俞募相配，是一种很好的配穴方法。除常应用上列各穴外，任脉之上脘穴亦有时应用，上脘乃足阳明、手太阳、任脉之会。手厥阴心包絡經之內关穴亦为常用之有效穴。

針治手法：进針后，捻轉約10—30秒鐘，即行退針；或于进針后，留針5—10分鐘。

十一、小兒幽門痙攣

小兒幽門痙攣症多見于初生后至5、6个月之間，这一阶

段为幽門痙攣症的易发期。

病因：胃腸道受大腦皮質調節。由于中樞神經系統的神經調節失常，受到刺激，幽門部的植物神經興奮變化，支配幽門的迷走神經過度興奮，迷走神經中之互交感神經影響幽門括約肌收縮加快而成痙攣。由此可見，幽門痙攣並非全部，是幽門局部的機能病變，乃系皮質內臟間的病理反射。

症狀：幽門痙攣的初期症狀大都出現于生後2—3星期。小兒于喂奶后立即發生嘔吐，或于至半小時後發生嘔吐，嘔吐常呈噴射性，每天由數次至十數次。尿量減少，大便時常秘結，體重停止增加甚至減低。望診時于上腹部可看到自左向右的胃蠕動波。

針灸療法：幽門痙攣雖然可用阿托品治療，但有發生阿托品中毒之可能。有些患兒應用阿托品治療效果欠佳。因此，作者自1955年開始試用針灸治療小兒幽門痙攣症。在試用針灸治療小兒幽門痙攣症的實際工作中，体会到針灸療法有促進小兒幽門痙攣恢復正常的作用，并且体会到下列各穴是針治小兒幽門痙攣的有效穴。

針治取穴：足三里、內關、合谷、中院。

針治手法：進針後，捻轉約10—30秒鐘左右，即行退針。

病例一：患兒趙××，女，2個多月，住院號34056，于1956年3月28日入院。主訴：嘔吐已兩個月。患兒自初生以來，每次吃奶後即嘔吐，有時吃奶後立即將奶吐出，有時于數分鐘或十幾分鐘或1—2小時後將奶吐出。嘔吐時常呈噴射狀。大便秘結，時常3—4天一次。檢查：營養甚差，呈消瘦狀，發育不良，腹軟，有時可見胃蠕動波。診斷：幽門痙攣及營養不良第Ⅲ度。X射綫鋇餐胃腸檢查時見胃部充盈良好，粘膜、蠕動、柔軟度、移動度正常，幽門部初無痙攣現象，后



針灸治療前，因患幽門痙攣引起嚴重嘔吐而致
營養不良



針灸治療后，嘔吐停止，體重顯著增加

圖 18 幽門痙攣(王文龍)

則呈持續性閉鎖，竇部長期呈錐狀。放射科同意小兒科之意見，診斷為幽門痙攣症。患兒于入院後曾用阿托品、魯米那等藥物治療三星期之久，並未見效，每日嘔吐4—5次，甚至9次之多，時常呈噴射狀。身體消瘦，一般情況欠佳，精神不振，乃于1956年4月21日請針灸科會診，開始試用針灸治療。針足三里(雙)及內關(雙)一次後，嘔吐即見好轉；第二天嘔吐次數減至一天3次；經第二次針灸後，嘔吐次數減至一天1次。一般情況好轉，精神亦佳，體重增加。針至6次後，嘔吐消失，結果痊癒。營養不良，亦見好轉。

病例二：患兒王文龍，3個多月，男孩，于1957年3月15日入院。主訴：嘔吐已三個多月。患兒自生後三天即開始嘔吐。嘔吐時常為噴射性，自口鼻外噴，并大口吐奶及溢奶，吐量很多。患兒于吃奶或喝水後約2—3分鐘後即嘔吐，因而日漸消瘦。檢查：營養不良，呈消瘦狀，腹軟，有時可看到不太明顯之胃蠕動波，未觸及腫物。診斷：(1)幽門痙攣，(2)營養不良第Ⅱ度。經針刺足三里(雙)、合谷(雙)及內關(雙)一次後，噴射性嘔吐即消失，每天僅溢奶1—2次，量亦減少。針治14次後，溢奶消失，精神好轉，一月之內，體重由3.8公斤增加至4.5公斤。結果痊癒。

十二、小兒單純性消化不良

單純性消化不良，又叫做消化不良性腹瀉，系急性的消化紊亂，是小兒科常見疾病之一。

病因：喂奶及次數過多，喂养食物的成分不适当或驟然改變；过早的添加輔助食品或喂养不足等均能使消化紊亂，引起單純性消化不良，發生腹瀉。夏季的炎熱与小兒的過熱也是單純性消化不良的重要因素。

症狀：腹瀉是單純性消化不良的主要症狀。患兒大便次數增多；一日5—8次甚至十數次。便內含有大量液體或粘液，呈綠色或黃綠色，帶有白色小塊，且有酸臭味。在腹瀉嚴重時，糞便呈水樣，其中混有綠色的糞渣。排便前患兒有哭叫不安的現象，乃因腸痙攣所致。除腹瀉外，溢乳與嘔吐也是單純性消化不良常見症狀。小兒于吃奶後立刻或經數分鐘或經15—30分鐘溢出凝固或未凝固的乳汁。體重不增，甚至減輕，腹部膨脹，舌上有苔。大便顯微鏡檢查有脂肪球及粘液。

針灸療法：自1953年8月至1954年12月，原北京市第一兒童醫院曾有28例單純性消化不良患兒，經用藥物及飲食療法久治未效，乃試用針灸治療，27例于針刺雙側足三里穴後迅速痊癒，一例顯著好轉。有一病例：石××男孩，六個月，系人工喂養兒，住院號2084。于1953年8月6日開始針灸治療時，腹瀉已17日。在針灸治療前，患兒曾在我院用表飛鳴、乳酸鈣及維生素乙₁₂等藥物治療，并曾禁食12小時，均未見效，而腹瀉次數由每天7—8次增加至16次以上，大便呈稀水樣不消化便。經用針灸治療1次後，即顯著好轉；3次即告痊癒。針治取穴為雙側足三里穴。通過實踐，使我体会到針灸療法可能是治療單純性消化不良的一種特效療法，是值得廣泛試用并深入研究的。

為了進一步研究單純性消化不良的針灸療法，北京市兒童醫院針灸科于1955年初擬訂了針灸治療單純性消化不良的研究計劃，并得到中央人民政府衛生部、北京市公共衛生局及本院領導與醫學科學研究委員會的重視，列為國家醫學科學研究題目之一。這一研究工作系在我院醫學科學研究委員會的指導下及我院小兒內科、化驗室、細菌檢驗室等有關部門協助在門診分兩個步驟進行的：

(一) 自 1955 年 1—7 月, 所有該病患兒, 不采用禁食等飲食療法(但對不合理的錯誤的喂養法, 則加以糾正), 亦不采用藥物療法, 僅用針灸治療, 共計 78 例, 結果如下:

結 果				病例总数	痊愈率	平均治愈日
痊 愈	显著好转	进 步	无进步			
73	3	1	1	78	93.6%	2.7 天

通过實踐, 使我們深刻体会到針灸療法對於單純性消化不良, 確有良好療效。

(二) 于 1955 年 8—9 月份, 做了對照試驗。將門診治療單純性消化不良之患兒分為兩組:

(1) 針灸組: 每星期二、四、六上午來院初診的患兒應用針灸治療, 並配合飲食療法及藥物療法做為輔助治療。除針灸治療外, 初診時先禁食 6 小時, 且服用表飛鳴、維生素乙₁ 及乳酸鈣。

(2) 對照組: 每星期一、三、五上午來院初診患兒應用飲食療法及藥物治療。于初診時先禁食 6—12 小時, 禁食期間多次喂給涼開水、淡茶水或 3% 葡萄糖水。母乳喂養的患兒于禁食 6—12 小時後, 喂少量母乳并逐漸增加至常量, 哺乳時間, 逐漸由 5 小時恢復至 4 小時一次或 3 小時一次; 人工喂養的患兒于禁食 6—12 小時後, 喂稀釋的牛乳并逐漸恢復至正常量, 喂奶時間由 5 小時一次逐漸恢復至 4 小時或 3 小時一次。除應用飲食療法外, 并用表飛鳴、維生素乙₁、乳酸鈣、胃蛋白酶合劑(內含胃蛋白酶与稀盐酸)及凝酸蛋白等藥物治療。患兒于開始治療前, 均經詳細詢問与記錄病歷, 并詳細檢查。茲將針灸組及對照組病歷分析結果報告如下:

分 組	开始 末 院	診 疗 前 腹 瀉 日 数	喂 养 方 法				营 养 不 良 向			每 天 大 便 次 数					大 便 性 状		嘔 吐	精 神 不 振	煩 躁	病 情	
			母 乳 喂 养	人 工 喂 养	混 合 喂 养	嬰 儿 飯	第 一 度	第 二 度	傷 病	4 次 以 內	5 — 8 次	9 — 12 次	13 — 16 次	17 — 20 次	水 样 便	消 化 不 良				重	輕
針灸組	平 均 13.3天		11	13	7	2	3	4	10	8	15	9	0	1	21	12	13	11	2	28	5
对照組	平 均 7.9天		14	13	5	2	4	2	11	12	17	5	0	0	23	11	11	9	0	25	9

針灸組及对照組患兒經治疗后結果如下：

分 組	病 例 总 数	有 效			无 进 步	痊 愈 率	平 均 治 愈 日	最 短 治 愈 日 及 其 人 数
		痊 愈	显 著 好 轉	进 步				
針灸組	33	32	1	0	0	96.9%	2.1天	有17人于針灸后一天內痊愈（針灸一次后痊愈）
对照組	34	25	0	4	5	73.5%	5.7天	仅有一人于应用飲食疗法及葯物治疗后兩天内痊愈

由上表可看出針灸組的重病人較多、疗效較佳，因此，体会到針灸疗法对于單純性消化不良症確有良好疗效。

当作者于1953年8月开始試用針灸治疗單純性消化不良时，采用了足阳明胃經的足三里穴。当时，我认为單純性消化不良既然是急性的消化紊乱，而胃腸均在肚腹之內，采用足三里穴治單純性消化不良是合乎“肚腹三里留”的經驗的。同时，也是与马丹阳天星十二穴歌所記載的“三里膝眼下，三寸兩筋間；能通心腹脹，善治胃中寒；腸鳴并泄瀉，……”是符

合的。

作者在应用与研究針灸治疗单纯性消化不良的实践中，单独針刺足三里穴，即可能治愈单纯性消化不良症，充分证明了經絡学說对于針灸治疗取穴确有指导意义。原因是足三里乃系阳明胃經之合穴。除經常应用足三里为主治穴外，亦常配合手阳明大腸經的合谷穴及大腸的俞穴大腸俞。若患儿于除腹瀉外兼有嘔吐时，則常配以手厥阴心包絡經的内关穴。

針治单纯性消化不良时，可隔日或每天針治一次。应用的手法是进針后，待“气至”时，再捻轉約 10—20 秒鐘，即行退針。

除針治外，再配以灸治法为輔助治疗，則效果更佳。灸治时，作者最常采用天樞穴，此外，亦有时灸任脉之神闕穴。为嬰、幼兒灸治时，最好应用回旋灸法，每次每穴灸 3—4 分鐘。

腹脹严重的患儿，針刺足三里穴虽可能使腹脹減輕，但有时尚难令人滿意。可同时再行指針关元与兩側天樞穴，对腹脹的疗效往往很好。操作的方法是以左手拇指在关元穴上按压之，同时以右手拇指与食指揉按兩个天樞穴，每次約 3—4 分鐘。

对单纯性消化不良症，宜用針灸治疗，并糾正錯誤的喂養法，即能痊愈。若再配合以飲食疗法及葯物疗法，則疗效更佳。

病例：患儿章××一岁，男孩，人工喂養儿。于 1955 年 5 月 27 日开始針灸治疗时，腹瀉已 46 日之久。以前用飲食及葯物疗法，曾用过鞣酸蛋白、乳酸鈣、維生素乙₁及金霉素治疗，并禁食 14 小时，服中葯 12 天，亦未好轉，大便次数反由每天 6 次左右增加至每天 9—14 次之多。診查时，見患儿舌有

白苔，腹軟但膨脹。大便檢查：黃色水樣稀便，脂肪球(+)，粘液(+)。診斷為單純性消化不良。患兒于針刺雙側足三里穴一次後，腹瀉即顯著好轉，大便次數減少至每天2—4次，大便由黃色水樣稀便轉變為黃色軟便，顯微鏡檢查未見異常。針治兩次後痊癒。

十三、小兒腸痙攣

腸痙攣是小兒常見症狀之一，是一種陣發性腹痛症。

病因：腸痙攣系因腸痙攣或腸阻塞所致。胃腸道和其他臟器一樣也受大腦皮質調節。大腦皮質與向腸方面發出抑制和興奮衝動的皮質下部有密切的聯繫。由於這種神經調節障礙，而發生腸痙攣、急性消化不良、便秘、腸胃充氣及上呼吸道感染等症。此外，患腸套迭、腸扭結、急性闌尾炎、急性腸炎及蛔蟲症時，都能發生腸痙攣症。

症狀：患兒突然發生陣發性腹痛，腹痛大都在臍部。發作時呈不安狀，啼哭慘叫，兩腿彎曲，腹部往往因腸內產生大量氣體而膨脹。如此反復發作，每次發作持續約數分鐘，有時越發越重。

針灸療法：腸套迭、腸扭結及急性闌尾炎等外科疾病所引起之腸痙攣，宜急速用外科手術醫治，非針灸療法之適應症。因此，對腸痙攣患兒，必須詳細診查。若腸痙攣因急性腸炎所引起，則宜用磺胺類藥物治療。由於多數蛔蟲于腸內扭結成團引起腸梗阻的腹痛，應用氧氣驅蟲法往往有效。若患兒之腸痙攣乃因少數蛔蟲引起，則可應用針灸治療待腸痙攣消失後再用使君子等驅蟲藥物根本治療之。

對於急性消化不良、便秘、腸胃充氣及上呼吸道感染等所引起之腸痙攣，均可以針灸治療，並能迅速收效。

針治取穴：針足三里(雙)、合谷(雙)。

針治手法：進針後，捻轉約 15—30 秒鐘左右，然後退針，或於進針後，留針 5—10 分鐘。

灸治取穴：灸天樞、關元或神闕。

灸治手法：應用回旋灸法，每穴每次灸 3—5 分鐘。

病例：患儿黃××，6 岁，女，門診号 641467。于 1956 年 10 月 26 日初診，主訴：腹痛已 17 小时。患儿自 1956 年 10 月 25 日下午 6 点突然腹痛。因腹痛剧烈，哭叫不止，一夜未能安睡。腹痛部位系在脐部。未嘔吐，亦未發燒。曾服魯米那 (Luminal) 及顛茄酞 (Tr. Belladonna) 等葯物治疗，腹痛仍很剧烈。診查時見患儿正在腹痛，哭叫不止，呈剧烈疼痛状，腹軟，无肌緊張及肿块，未見腸型，左下腹部有压痛，拒按，白血球：8200/cu mm. 多核：75%，淋巴：25%。印象：腸痙攣痛。針刺足三里穴後，腹痛立即消失。復灸天樞穴。針灸後患儿安然入睡。

十四、小兒便秘

便秘是小儿常見症狀之一，原因很多。

病因：

(一) 腸部機能失常：营养不良、佝僂病及克汀病的患儿往往兼腸壁弛緩而发生“弛緩性便秘”。由于生活習慣不正常，或缺乏体育活动，腸蠕动力微弱与缺乏按时大便的習慣，排便的条件反射难于养成，因而发生便秘。患慢性病後，亦常由于腸壁弛緩，軟弱无力，而发生“无力性便秘”，或称“弛緩性便秘”。經常用泻剂与灌腸，亦可能使腸部機能失常，因而发生便秘。有些病例，便秘可能因植物神經系統功能不正常，因而腸部缺乏緊張力所致。大腦皮質的機能状态及其在維持腸

緊張力与运动上的調節作用减弱对腸无緊張力状态的发生，乃其重要原因。

(二) 飲食不足：由于母亲乳量不足又未适当地給予牛奶，或用稀釋过分的牛奶等，均可引起“飢餓性便秘”。小儿飲食若太少，經過消化后，余渣很少，就自然缺乏大便。水分不足也能使大便干燥秘結。飲食不足即可引起营养不良，腹肌軟弱，腸肌軟弱，缺乏推动力，因而引起大便秘結。

(三) 食物成分不适宜：若食物的炭水化合物含量不足时，腸蠕動就会减低，因而发生便秘。若食物含有多量蛋白質和脂肪，就会发生大便干燥。若所吃食物缺乏渣滓，就容易发生便秘。

(四) 幽門狹窄：先天性幽門肥大性狹窄的患儿时常便秘。

(五) 肛門裂伤或炎症：小儿肛門部若有裂伤或炎症时，患儿由于惧怕排便时疼痛而强忍不排便，因而引起便秘。

症狀：大便干燥坚硬或数日无大便。而有哭叫不安、不能入睡、食欲不振、精神欠佳等現象。

針灸療法：針灸療法有矯正習慣性便秘而促使其恢复正常的的作用。除应用針灸治疗外，应根据病原治疗其本；矯正飲食不足及食物成分，訓練按时排便的良好习惯，并注重日常的体育活动。

針治取穴：足三里、天樞、支沟、大腸俞。

針治手法：进針后，捻轉約 10—30 秒鐘，即行退針。

灸治取穴：天樞、气海、大横、大腸俞等穴。

灸治手法：用回旋灸法，每次灸 3—5 分鐘。

病例：患儿周××，女孩，5岁。于1954年11月28日初診，主訴：自幼即大便經常干燥秘結，排便困难。自昨日

起，大便尤为干燥，以致不能排便。检查：营养中等，舌苔厚呈黄白色，腹软无压痛。针足三里与大肠俞后，用回旋灸法灸天枢穴时，患儿肠鸣有欲便感，便出燥屎颇多，立感舒适，此后每天大便 1—2 次，结果痊愈。

十五、小兒夜間遺尿症

夜間遺尿症是兒童常見的疾病。兒童于夜間睡眠中排尿叫做夜間遺尿症。2—3 岁或更小的小兒于夜間遺尿，是一種生理現象。若三周歲以上的兒童于夜間睡眠中不能控制因而遺尿才能叫做夜間遺尿症。

病因：根据 Духанов 氏意見，兒童夜間遺尿症乃因大腦皮質興奮性減低所致。當大腦皮質對來自膀胱的刺激의 警衛機能消失或減弱時，出現不隨意的排尿。

巴甫洛夫氏曾經指出：在正常睡眠時，大腦皮質中有不完全的抑制。睡眠正常的人的大腦皮質仍然遺留個別的覺醒點（警戒點或稱值班點），繼續執行許多重要的功能。因此，在正常的 3 歲以上的兒童及成人，能于夜間睡眠中自動醒來排尿。患夜間遺尿症的兒童，一般于夜間都睡得很熟，不能感到尿意自動醒來排尿。抑制已經擴散到了全部大腦皮質細胞，因此覺醒的警戒點（值班點）就不存在了，所以出現遺尿于床的不正常現象。

臨睡前飲入大量液體、教養上的缺欠、智力不足、精神創傷等都是促成兒童夜間遺尿症的因素。

脊椎的腰骶部的機質性異常，如隱性脊柱裂及脊柱裂亦常引起遺尿症。

症狀：小兒于夜間遺尿，一次甚至數次，或隔 1—2 天至數天遺尿一次或數次。患兒熟睡難醒，不但不能驚醒，有些還

能在潮湿衣褲中或潮湿的床褥上繼續睡眠。夜間遺尿症的患儿多数自嬰兒时期即經常发生或間歇性的发作。

針灸療法：患儿的夜間遺尿症用針灸治疗后，可能痊愈、近愈、显著好轉或好轉。若因脊柱裂或隱性脊柱裂所致，則非針灸所能治愈。

患儿于夜間熟睡遺尿，經針灸治疗后即能于熟睡中感到尿意而自动醒来排尿。

針治取穴：关元、中极及三阴交，气海及腎俞亦有时应用。

針治手法：进針后，捻轉約 10—20 秒鐘，即行退針。

灸治手法：用回旋灸法灸腎俞 3—4 分鐘，作为輔助療法。

病例：患儿白××，9 岁，女，門診号 62528。于 1954 年 2 月入院就診，主訴：从小即每夜遺尿一次。檢查：无异常发现，診斷为夜間遺尿症。經用針灸治疗 3 次后，即能于夜間睡眠中当膀胱脹滿时感到尿意，自动醒来排尿。針治取穴：三阴交。

十六、膀胱肌痙攣

病因：膀胱及其括約肌受植物神經系統支配：副交感神經功用是使膀胱逼尿肌收縮而且使膀胱內括約肌松弛；交感神經功用是使膀胱逼尿肌松弛而且使膀胱括約肌收縮。副交感神經在膀胱排尿的机理上居于主动地位，交感神經的作用則較為次要。副交感神經与交感神經之間虽然有部分的对抗作用，但在正常时副交感神經与交感神經彼此保持平衡。

来自第三与第四骶节的阴部神經的軀干神經系尿外括約肌的运动神經，功用是随意节制排尿。

在正常时，膀胱内积尿相当多时，即有感觉神经冲动传入中枢，发动排尿反射。在意志节制的排尿动作中，神经冲动由大脑皮质下行，通过各神经而达到膀胱，使膀胱逼尿肌收缩而且使内括约肌松弛。若当时环境不便进行排尿，而且膀胱并非过度膨胀时，大脑皮质于必要时对脊髓反射与膀胱的收缩发生阻抑作用。若上运动神经单位对脊髓反射失却了阻抑作用，即能引起无抑制性的神经性膀胱机能失调。由于膀胱逼尿肌的痉挛，因而发生尿频等症候。

症状：主要症状是尿频。患儿尿意频数，并有尿急等现象。在积尿过程中，膀胱逼尿肌呈无抑制性收缩。膀胱每次收缩时，即有排尿的感觉，因而尿频。

针灸疗法：针灸疗法有加强大脑皮质调节与管制排尿的作用，故能促进膀胱痉挛的恢复。无抑制性的神经性膀胱机能失调的患儿于针灸治疗后，可能迅速痊愈、近愈或显著好转。

病例：患儿李××，6岁，女，门诊号64939。于1954年3月来我院初诊，主诉：一月来小便频数，每天小便次数多至20—30次，且有尿急等现象。检查：身体及小便均无异常发现。诊断：无抑制性的神经性膀胱机能失调（膀胱痉挛）。针刺三阴交（双）及肾俞（双）一次后，效果很好，每天小便次数即显著减少。针治3次后，每天小便次数恢复至每天约4—5次。结果痊愈。

针治取穴：最常应用的穴位是三阴交与关元。肾俞、阴陵泉、中极与气海亦有时应用。

针治手法：进针后，捻转约15—30秒钟，即行退针。

十七、小兒尿瀦留

尿瀦留于膀胱內難以排出，叫做尿瀦留，即祖國醫學書籍中所記載之“癰閉”，為一極度的排尿困難。

病因：當膀胱內括約肌發生痙攣，或膀胱逼尿肌的緊張力消失或呈嚴重的弛緩時，均能使排尿困難，發生尿瀦留。

症狀：尿瀦留的主要症狀為排尿困難。溺“癰”患者小便不利，排尿困難。溺“閉”患者則排尿極度困難，小便点滴難下。若系膀胱逼尿肌麻痺，當膀胱充滿尿液無力將尿排出，而現小腹脹滿。膀胱膨脹越嚴重，則越增加膀胱逼尿肌之麻痺及使膀胱變為鬆弛，最後不用導尿管就不能將尿排出。若系膀胱括約肌痙攣，則會因膀胱括約肌之痙攣性強烈收縮而排尿困難，甚至發生尿閉。所謂“神經原性膀胱”的患者，因調節與管制膀胱及其括約肌之神經系統發生紊亂，引起排尿困難甚至閉止，即為尿瀦留。

針灸療法：針灸療法有調節膀胱逼尿肌麻痺或膀胱括約肌痙攣的恢復作用；針灸療法能加強大腦皮質調節與管制排尿動作的能力，促使“神經原性膀胱”患者恢復正常的作用；因此機能障礙性尿瀦留患者經針灸治療後，往往收到很好的效果。用導尿管導尿，有引起膀胱炎的可能，而針灸療法則無此流弊，故比較安全。

尿瀦留患者宜及早應用針灸治療，因為及早治療，效果較好。若膀胱過度膨脹時再行針灸治療，則其療效不如早治為佳。若尿瀦留系因機質性病變，如尿道發生機質性狹窄，則非針灸所能治愈，宜用手術或擴張術等療法。

針治取穴：針三陰交、陰陵泉、足三里。

針治手法：進針後，捻轉約10—30秒鐘。即行退針。

灸治取穴：灸关元、中极。

灸治手法：应用回旋灸法，每穴每次可以灸3—5分钟。

病例：患儿沙××，两个半月，女，住院号121735。于1957年11月2日因3日来不能排尿（因患尿潴留）而入院诊疗。入院后因不能自主排尿，每日于下腹部热敷，并进行导尿。因患儿住院经诊疗8天后，仍不能自主排尿，乃请针灸科会诊。针三阴交、阴陵泉及足三里穴，并灸关元穴两次后，即能自动排尿。共针灸3次，结果痊愈。

十八、支气管喘息

病因：支气管喘息多发生于8—12岁的小儿。支气管喘息是机体的过敏状态。发生支气管喘息的首要因素是大脑皮质调节支气管肌肉活动的皮质下部的机能障碍，引起支气管的植物神经系统的机能紊乱，引起迷走神经系统兴奋性增强，以致支气管肌痉挛，因而发生支气管性气喘。

支气管喘息是由于中枢神经系统的反应性改变，使机体对于各种过敏原的感受性增高所引起的过敏状态。各种气味（例如花粉、毛发、尤其是猫、狗、马等动物的皮所发生的气味等）都可能成为过敏原引起支气管性气喘。或是由于食用某些食物（例如鱼、鸡蛋等）引起的。服用奎宁或柳酸制剂等药物亦有引起支气管性气喘发作的可能。细菌亦可能成为引起支气管气喘的过敏原。

症状：年长儿的支气管性气喘症状与成人相似。年幼儿气喘的症状则稍有不同。

支气管喘息的主要症状为剧烈的呼吸困难。气喘发作时吸气期缩短，而呼气期延长。患儿因吸气不充足而贪婪地吸气，伴有哮喘，发作时在患儿附近有时可听到哨笛声，胸部听

診時，可聽到肺部滿布干性笛音性羅音。氣喘發作時，患兒唇及四肢發紺，精神顯著不安。氣喘發作後，精神萎靡無力。患兒氣喘可能有不定的周期性反復發作，通常夜間較重，而不能平臥。嚴重的呼吸困難可能持續2—3小時，甚至更久些，然後呼吸困難逐漸減輕，並吐出多量帶有泡沫的稠痰。氣喘可能於數小時後或次日重復發作，支氣管性氣喘的反復發作，可能持續數日，然後進入安寧期。經過相當時期，患兒可能又重新出現支氣管性氣喘的反復發作。于安寧期內，一般自覺良好。

患兒于氣喘發作期吐出來的痰內，含有夏科-雷盾（Charcot—Leyden）氏結晶，枯什曼（Curschmann）氏螺旋體及大量的嗜伊紅細胞。血液檢查時有時可發現嗜酸細胞的增多。支氣管喘息患兒用過敏原作皮膚試驗時，常呈陽性反應。

針灸療法：針灸療法能加強大腦皮質的調節與管制機能，能促使大腦皮質機能紊亂恢復正常，故可能促進支氣管性氣喘的恢復，使氣喘減輕和減少氣喘的反復發作。若能持續較長時期針灸治療，可能得到痊癒、近癒或顯著好轉的效果。

針治取穴：椎旁、大杼、風門、肺俞、合谷、曲池。

針治手法：進針後，捻轉約10—30秒鐘，即行退針。

灸治取穴：椎旁、大杼、風門、肺俞、每次灸3—4分鐘。

病例：患兒劉××，10歲，男。于1954年10月14日來我院針灸科初診，主訴：為近十余日氣喘不止。患兒自4年前開始時常氣喘，尤以秋冬兩季喘息發作最勤。十余天來氣喘又發作而且嚴重，夜間氣喘較重。除氣喘外，並有咳嗽，且有帶泡沫的粘稠痰咳出。喘息發作時，患兒感到呼吸困難。曾用麻黃素治療，但效果不佳，故來針灸。檢查：營養中等、咽紅、扁桃腺稍大。患兒吸氣期縮短，而呼氣期延長且伴有哮

鳴，在患儿附近可听到哨笛声，唇及指甲发紺，呈呼吸困难状。胸部听診时听有干性笛音性罗音。診斷：支气管喘息。患儿經針刺合谷、大杼、风門、肺俞一次后，气喘即消失，将近一年之久未有发作。于次年9月21日又气喘发作一次，經針刺合谷及肺俞一次后，喘息減輕。繼續針灸治疗，喘息消失，至今已很久未再有喘息之发作，前后共針灸41次。

十九、急性扁桃腺炎

急性扁桃腺炎，也叫做咽峡炎，俗称“喉痹”或“乳蛾”。

病因：由于鏈球菌、肺炎双球菌或葡萄球菌等感染所致。神經系統調節机能的失調是发生急性扁桃腺炎的主要原因。由于疲劳过度；精神受刺激；气候驟然改变，以致身体抵抗力减弱。因而鏈球菌、肺炎双球菌或葡萄球菌等乘虛侵入，因而引起急性扁桃腺炎。

症狀：发燒、咽部疼痛。吞咽时咽部疼痛加剧，因而畏食，甚至飲水也减少。有的患儿且有寒战、头痛及关节痠疼，食欲不振，或有嘔吐等症狀。

局部症狀有扁桃腺紅腫。在急性扁桃腺炎患儿，則見扁桃腺紅腫，扁桃腺表面上及其深处并无伪膜。在急性滤泡性扁桃腺炎，在发炎的扁桃腺上有白色或黄白色的如針头或豌豆般大小的乳块状伪膜，这种伪膜容易除去。在急性陷窩性扁桃腺炎，在扁桃体深处有黄白色小斑点。急性扁桃腺炎患儿时常伴有頸部淋巴腺腫大。檢查血液时，常有白血球显著增高的現象。

針灸療法：針灸療法有促使急性扁桃腺炎痊愈的作用。对于急性扁桃腺炎患儿的咽部疼痛，有良好的止痛作用。

、針治取穴：合谷、少商、頰車。

針治手法：進針后，捻轉約 15—30 秒鐘，即行退針。針刺少商穴后，宜遵循“熱則疾之”的原則，于針刺后急出其針，以瀉其熱。若于刺少商后，放一點血，更有助于退燒的作用。

一般患兒僅用磺胺類藥物或針灸治療均可。對於嚴重患兒，除針灸治療外，宜配合以磺胺類藥物或青霉素等藥物治療。

病例：患兒黃××，12 岁，男孩，門診号 34093。于 1956 年 3 月 29 日入院，主訴：咽部疼痛已 4 天。患兒于 3 月 26 日开始發燒，并出現咽部疼痛，吞咽食物或飲水时甚至咽唾液时咽部疼痛均覺加重。曾服磺胺嘧啶等藥物，并且注射青霉素，但咽部依然疼痛，吞咽及飲水时咽痛仍甚严重。望診：見患兒扁桃腺腫赤均甚严重，右側扁桃腺上且有黃白色偽膜。頸部兩側淋巴腺均腫大，且有壓痛。咽部拭子培养出甲類鏈球菌。診斷：急性濾泡性扁桃腺炎“單乳蛾”。患兒經診查后，立即施行針治。于針刺合谷及頰車后，咽部疼痛立即解除。患兒甚感惊奇，吞咽唾液，亦未感覺咽痛。檢查：扁桃腺已不腫赤，扁桃腺上之黃白色偽膜亦已消失。頸部淋巴腺腫大及壓痛亦均消退。結果：針治后迅速痊愈。

二十、腰椎麻醉后头痛

病因：腰椎麻醉后常并发头痛。有人認為腰椎麻醉后头痛的原因系因腦脊髓液由腰椎穿刺孔外溢，致顱壓降低所致。

症狀：患者于腰椎麻醉后发生头痛。有些患者于平卧时仍有头痛，于坐起或下地时头痛則更加严重。头痛部位多在顳部，額部或枕部，有时位于頂部。头痛多于腰椎麻醉后数小时至 1—2 天后发生。搖頭，咳嗽或用力时头痛往往加重。

比較严重之患者除头痛外，往往同时有恶心、嘔吐等症狀。

針灸治療：很多腰椎麻醉后患者頭痛非常严重和痛苦，实難忍受；因此北京协和医院針灸治療室李綺芳同志自 1955 年 8 月，試用針灸治療腰椎麻醉后頭痛 84 例，結果有 81 例子針灸治療后迅速痊愈，平均治愈日為 2.01 天。其余 3 例亦显著好轉，只因急欲出院，而未能完成治療。很多患者于开始針治前頭痛严重，即使在平卧时仍有較重的頭痛，于坐起或下地时頭痛則更加严重。很多患者顰眉閉目、怕震，甚至出冷汗、躁動不安，有时哭泣。針治后絕大多數患者立即痛止。有些患者于初次針治后頭痛立即消失而未再发作。有些患者虽然于初次針治后立即止痛，經過数小时或十几小时后頭痛复发，但其頭痛程度較未針治前显著減輕，經繼續針治后頭痛完全消失而痊愈。

作者于应用針灸治療小儿腰椎麻醉后頭痛的實踐中，也收到很好的效果，患儿于針治后立即痛止，因而体会到針灸療法有促進腰椎麻醉后頭痛恢復的作用。

針治取穴：根据李綺芳同志試用針灸治療腰椎麻醉后頭痛的体会，腰椎麻醉后額部頭痛用头維与印堂效果較好；額部頭痛实用太阳与头維；枕部頭痛宜用风池与天柱；頂部頭痛宜用百会。除应按腰椎麻醉后发生頭痛的部位采取适当穴位外，亦应配合以列缺或合谷。作者于針治小儿腰椎麻醉后頭痛时，采用了上述取穴法。

針治手法：进針后，捻轉約 30 秒至 1 分鐘，即行退針。或于捻轉約 30 秒至 1 分鐘后，留針 5—10 分鐘，再行退針。

病例：患兒安×，13 岁，男。于 1957 年 2 月 5 日因患右侧先天性腹股沟斜疝入院治療。患儿于 2 月 7 日在腰椎麻醉下施行疝修补手术，經過順利，但于手术后发生頭痛头晕，暈

痛部位在前額，痛疹甚嚴重。患兒并感惡心，嘔吐3次。請針灸科會診。會診時，見患兒正處於嚴重頭痛狀態，患兒閉目，不愿睜眼，但臥于床上，雙手抱頭，頭不敢轉動。頭軟，克匿格氏征陰性，巴彬斯奇氏征陰性。印象：腰椎麻醉后頭痛。針印堂，合谷及列缺穴一次后，頭痛立即顯著好轉，收到立竿見影之效；針兩次后，即迅速痊愈。

第七章 通過針灸治療兒科病症的實踐

對針灸治病原理的認識與體會

針灸療法是祖國寶貴醫學遺產之一；數千年來應用針灸治病的寶貴經驗證明針灸治療範圍很廣，對好多種疾病確有療效。針灸為什麼能治病？這是一個值得而且需要研究的問題，謹將我對針灸治病原理的認識與體會提供出來，敬請專家們及同道們指正。

經絡學說在祖國醫學理論基礎中占着很重要地位，數千年來指導針灸療法應用於臨床而且行之有效，因此，對於經絡學說應當非常重視，而且應當深入鉅研學習。祖國醫學最古的醫書“內經”在經脈篇內明確指出：“經脈者，所以能決死生，處百病，調虛實，不可不通。”由此可見，經脈是非常重要的。

根據祖國的醫學記載，人身有十四經脈，所謂十四經脈，就是全身氣血循行的通路。氣血的循行，由手太陰肺經開始，以次經過手陽明大腸經，足陽明胃經，足太陰脾經，手少陰心經，手太陽小腸經，足太陽膀胱經，足少陰腎經，手厥陰心包絡經，手少陽三焦經，足少陽膽經及足厥陰肝經；然後由足厥陰

肝經又回到手太陰肺經；气血就是这样地在十二經內周而复始地循环不息。气血循行一周回到手太陰肺經以后，另有一个分枝：气血由手太陰肺經經過督脉与任脉，然后由任脉又回到手太陰肺經。十四經脉的支別，再加上脾之大絡，叫做十五絡脉。針灸刺激經絡后，可以起到疏通經絡、宣导气血、补虛泻实的作用，而能治疗疾病。（参考图 19：十四經循行示意图）

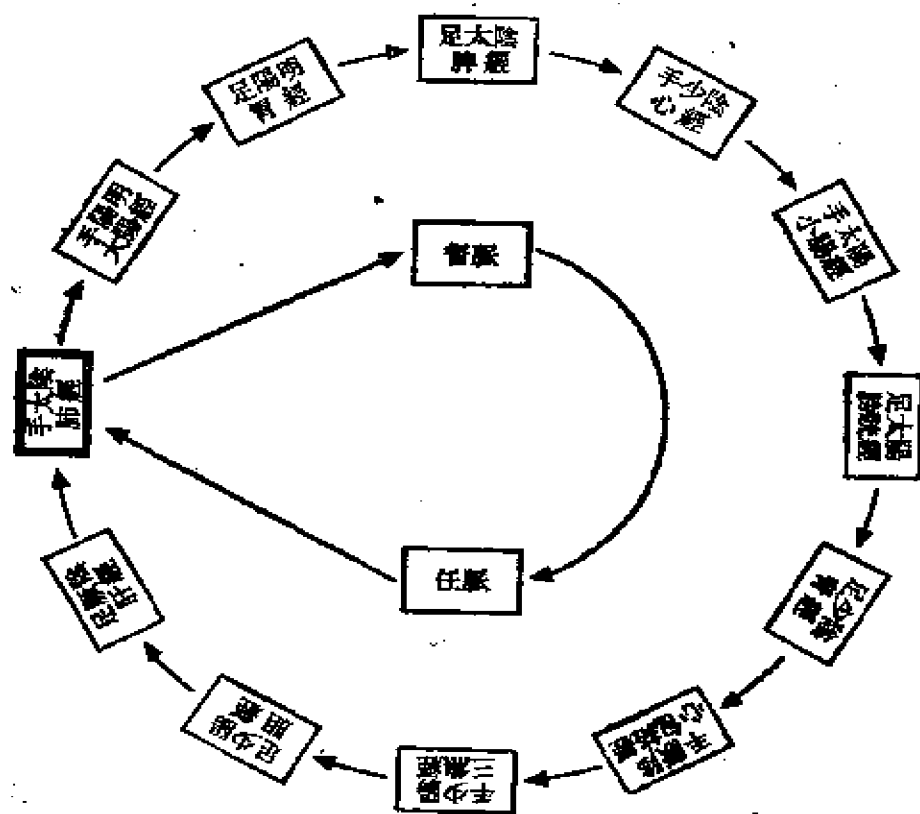


图 19 十四經循行示意图

十四經脉虽然在解剖上尙无迹象可寻，但在針刺經穴时痠、麻、脹等感觉的感傳路綫时常与十四經脉的循行路綫相符合。例如：針刺腎俞或大腸俞等經血时的痠、麻感，时常系沿

着足太阳膀胱經的循行路綫向下傳导的。

經絡学說表明了十四經上的經穴都分別与其有关之内脏发生关联。1947年，当我更深入一步学針灸时，先父任作田根据其四十年来应用針灸治病的宝贵經驗，曾強調指出：“某些經穴确实与某些内脏有密切联系。例如：針刺足阳明胃經的足三里穴对于急性胃炎等胃病，时常会发生极其明显而且良好的疗效。”不久以前，苏联乌克兰生理研究所的福利波尔特教授发现皮肤的某些部位(皮肤活动点)与其相关的内脏有特殊的密切联系，并且可由皮肤活动点的电位变化，测定与其相关的内脏的变化，而且已經发现中国的針灸疗法治疗某些脏器疾患所用的經穴，有很多是与苏联所发现的皮肤活动点与其相关内脏的关系是相符合的。因此，經絡学說对于針灸治疗取穴是有指导意义的，应当重視而深入研究的。

在应用針灸的临床工作中，初步体会到应用針灸刺激經穴，主要是刺激分布于該經穴的神經。当針刺經穴时，患者感到痠、麻、脹、沉重或触电样感觉，而且这种感觉时常可以傳到很远，例如：針刺足阳明胃經的足三里穴时常可以麻到脚背。由于針刺經穴时所产生的感觉，与神經受到刺激时所产生的痠、麻等感觉是相同的，例如：針刺足阳明胃經的足三里穴时所产生的痠、麻等感觉，是与刺激小腿的腓深神經时所产生的痠、麻等感觉是相同的。此外，針刺治疗某种病症时，若于針刺后适量放血(应用針刺放血的方法)的效果时常比单独針刺更为有效。例如：針刺少商穴，对于急性扁桃腺炎引起之高燒，虽亦有效，但不如針刺少商放血的效果明显而迅速。因而体会到針灸刺激經穴，主要是刺激分布于該穴位的神經；有时除刺激神經外，也同时刺激了血管。

根据治疗的体会針是物理疗法，灸亦相同；或使神經兴

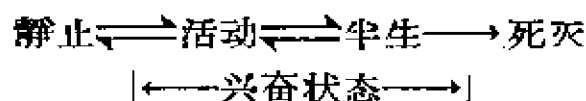
奋,或抑制神經。使我对于針灸治病的原理有了初步的認識,認識到針治是应用金属等制成的針刺激神經的物理疗法,灸治是应用艾絨等燃着后所产生的溫热刺激神經的物理疗法;应用針灸給予神經以弱刺激时,可以产生兴奋作用;給予神經以强刺激时,可以产生抑制作用;而能达到“虛則补之,实則泻之,”的目的。

通过維金斯基学說的学习,使我認識到这样的解釋是合乎維金斯基学說的。維金斯基氏在研究中曾发现:当用电流刺激神經的时候,在一定范围内,增强电流强度或增多刺激頻率,能使肌肉收縮相应地增强;但若繼續增强刺激电流即强度或增多刺激的頻率时,則肌肉的收縮反而减弱,甚至完全没有反应。維金斯基认为每一种具有兴奋能力的組織,能接受刺激而发生最大最适宜的反应,都必須有一定的最适宜的强度和頻率。这个最适宜的强度,叫做良性强度;这个最适宜的頻率,叫做良性頻率。良性强度和良性頻率,对于这种組織說来,就是良性刺激。如果刺激的强度和頻率超过了良性刺激的范围,就要引起抑制性反应。

在应用針灸治病的实际工作中,我們可以看到針灸疗法,不但可以促进与帮助顏面神經麻痹的恢复,而且可能促使顏面神經痙攣好轉。其中原理是可以应用維金斯基学說解釋的,因为維金斯基曾說:“生体組織对刺激的反应是兴奋还是抑制,主要由該組織的机能活动性来决定,而机能活动性又受刺激的質和量所影响。”外界刺激能够引起組織机能活动性的改变,較弱的或低頻的刺激可以恢复和提升組織的机能活动性,能够恢复和提升組織的兴奋能力。因此,应用金属等制成的針給予分布于絲竹空、瞳子髎、下关、听会、頰車及地仓等經穴的顏面神經以机械性的弱刺激时,能够給予顏面神經以良

性刺激,恢复和提高顏面神經的机能活动性,和提升顏面神經的兴奋能力,而能促进与帮助顏面神經麻痹的恢复正常。生体組織受过强或过頻的刺激时,机能活动性就会低下,而能引起抑制性反应。因此,应用金属等制成的針給予分布于絲竹空、瞳子髎、下关、听会、頰車及地会等穴的顏面神經以机械性的强刺激时,可使神經由高度兴奋轉变为抑制,引起抑制性反应,而能使顏面神經痙攣好轉。

維金斯基氏通过实验曾經証明:外界刺激如果过强或过頻,能使生体組織的机能活动性降低,以至变为零,能使生体組織的兴奋性与傳导性減退以至于完全丧失,甚至可能走向死灭。若将外界刺激及时除掉,組織亦有可能恢复正常的兴奋性与傳导性。維金斯基氏根据这个事实,于1901年提出了間生态学說,认为組織的这种間生态是一种特殊的变态的兴奋状态,对外的表現是一种抑制状态;而且认为間生态与兴奋是可逆的,相互移行的,間生态的发展与恢复,可以表示如下:



維金斯基氏发现当組織受外界劣性刺激时,引起組織机能活动性低下而向零的发展过程中,也就是在間生态发展过程中,出現一系列的位相变化:

- (1) 均等相: 組織对强刺激与弱刺激出現同等的反应。
- (2) 反常相: 組織对强弱刺激的反应,出現反常的效果,也就是强刺激却引起弱的效果,而弱刺激反而引起强的效果。
- (3) 抑制相: 組織对任何刺激,完全不反应。

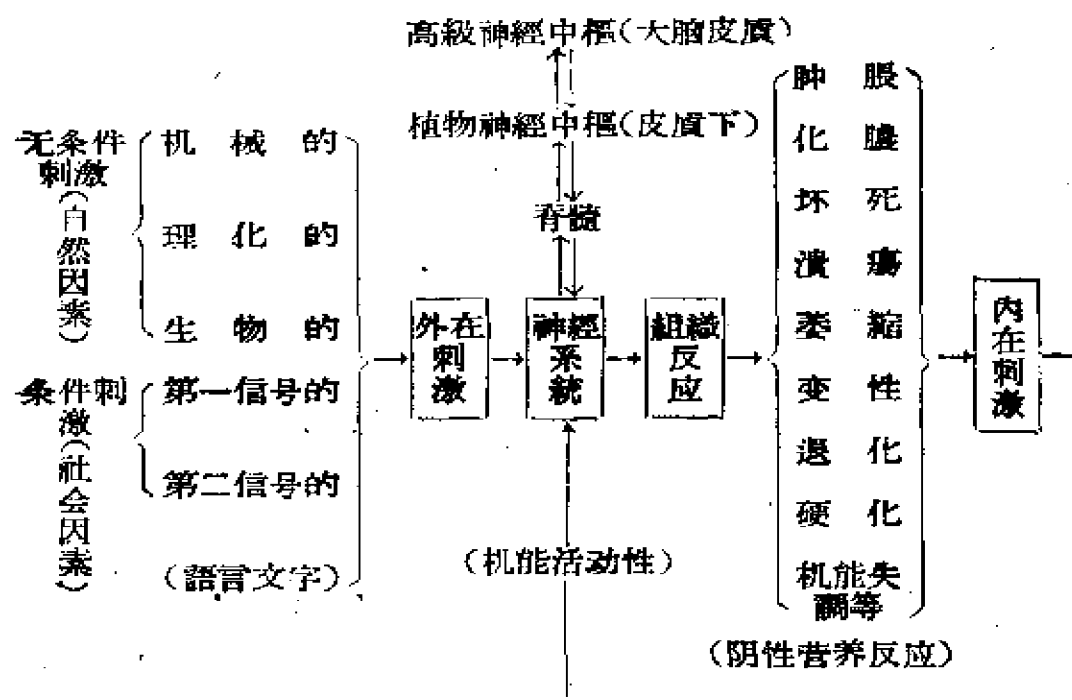
均等相、反常相与抑制相在半生发展和恢复过程中,是可

以相互移行的：

正常 $\rightleftharpoons$ 均等相 $\rightleftharpoons$ 反常相 $\rightleftharpoons$ 抑制相 $\longrightarrow$ 死灭

維金斯基氏在研究兴奋与抑制的實驗里，証明在組織机能活动性范围之内刺激愈强兴奋也愈大；但在組織机能活动性范围之外，則过度的刺激，反使組織由兴奋移行到阻抑。这說明抑制是在兴奋的基础上产生的，是由兴奋轉变而来的。根据維金斯基学說可以解釋应用金属等制成的針給予神經以机械性的弱刺激时，可以引起兴奋作用，达到“虛則补之”的目的；应用金属等制成的針給予神經以过强的刺激时，能使組織过度兴奋，而能在兴奋的基础上轉变为抑制，而能引起抑制性反应，达到“实則泻之”的目的。

当机体接受超过正常生理所能容忍的限度以外的刺激时，一方面由于刺激的質和量的不同，一方面由于个体神經系統的机能活动性的差异，而能引起組織产生各式各样的反应。刺激愈激烈或神經系統的机能活动性愈低下，則組織愈呈阴性营养反应，而能表现出肿胀、化脓、坏死、潰瘍、萎縮、变性、退化、硬化及机能失調等病理变化。这一类病理变化的本身，又成了內在刺激，再反过来影响神經系統，尤其是大脑皮質机能更为失常。如此往返循环不已，形成了病理的恶性循环。据斯別兰斯基氏的意見，肌体从接受刺激到出現反应中間的反射机轉如下：



由此可知发病的主要机轉是：病原刺激——神經系統——組織反应(阴性营养反应)。例如：当可以引起小儿麻痹症的滤过性病毒侵犯人体中樞神經系統，尤其是侵犯了脊髓前角灰質时，生体組織的机能活动性受到劣性刺激因而低下，甚至变为零，生体組織的兴奋性与傳导性减退，以至于完全丧失，也就是說生体組織移行为間生态，組織产生了阴性营养反应，因而引起肢体的麻痹。这种劣性刺激不但使局部神經組織移行为間生态，而且能促使大脑皮質机能失調，形成惡势循环。維金斯基氏认为間生态与兴奋是可以互相移行的，因而处于半生状态的神經組織可能移行到兴奋；也很可能走向死亡，而引起肢体的殘廢。为了想解除或減輕小儿麻痹症。

患兒肢體麻痺的痛苦，作者自1953年曾經試用針灸治療此病。數年來在應用針灸治療小兒麻痺症的實際工作中，体会到針灸療法有促進與幫助小兒麻痺症恢復的作用，并且体会到針灸能够促進與幫助小兒麻痺症恢復的原理，是可以根據維金斯基機能活動性學說與間生態學說加以解釋的，應用金屬等制成的針給予神經以微弱的良性刺激，能够提高神經系統的機能活動性，能使組織由陰性營養反應轉變為陽性營養反應，能够發生抗間生的作用，使脊髓前角內已被濾過性病毒侵害因而處於半生狀態的介乎生死之間的運動神經細胞移行到興奮，而且能够消除病理的惡性循環，并能恢復神經的興奮能力，使處於間生性抑制狀態的肌肉恢復，而能促進與幫助小兒麻痺症的恢復。因此，在應用針灸治療小兒麻痺及其後遺症的實踐中，可以看到小兒麻痺症經用針灸治療後得以痊愈、近愈、顯著好轉或進步。甚至麻痺已一兩年以上才開始針灸治療之小兒麻痺症後遺症，仍可能於長期針灸治療後有進步或顯著好轉。

中醫研究院魯之俊院長認為針灸療法有調整神經之功能，針灸治病的原理與蘇聯的神經病理學說極為一致。（魯之俊：新編針灸學，1及4—5頁，第一版，重慶人民出版社，1950）。朱璉院長認為針灸所以能够治病，主要是由於激發和調整身體內部神經的調節和管制機能。（朱璉：新針灸學，11，新1版，人民衛生出版社，1954。）；并曾提出針灸療法有幫助大腦皮質發揮保護性抑制作用的功能。（1952年健康報215期“針灸療法的實驗”）

根據巴甫洛夫高級神經活動學說，整個機體及其各部均處於大腦皮質調節與管制之下。全部植物神經系統（包括交感神經與副交感神經）亦處於大腦皮質調節與管制之下。根

据巴甫洛夫高級神經活动学說，大脑皮質为机体一切机能的管理者和支配者。根据貝柯夫氏大脑皮質与內脏相关学說，大脑皮質管制着一切內脏活动，大脑皮質可以調节一切內脏机能。巴甫洛夫氏认为神經系統，特别是大脑皮質，不仅在平常状态下調节机体各部；即在病的条件下，中樞神經系統的高級部位在調节机体机能協調与維持机体和环境的平衡上，也有着首要意义。这一首要部位的机能遭到破坏，便发展为疾病。

通过巴甫洛夫高級神經活动学說的学习，在应用針灸治疗小儿單純性消化不良及夜間遺尿症等多种疾病的實踐中，体会到針灸治病的原理是可以应用巴甫洛夫高級神經活动学說与貝柯夫氏大脑皮質与內脏相关学說加以解釋的。作者自1953年起在實踐中証明針刺足阳明胃經之合穴足三里，对于小儿單純性消化不良不但有疗效，而且疗效很好，使我深刻体会到經絡学說对于針灸取穴确有指导意义，而且体会到足三里穴与胃脏有密切联系。針刺小腿上的足三里穴不但能治疗單純性消化不良的腹瀉，而且也能治疗‘習慣性便秘。針刺同一穴位却能治疗相反的病症，盖因以針刺激神經后，能够加强大脑皮質的調节与管制机能，使大脑皮質兴奋与抑制兩基本神經过程的平衡得以恢复，故能治疗很多种疾病。作者在应用針灸治疗儿童夜間遺尿症的工作中，观察到一般患儿于針灸治疗前夜間睡熟而不能自动醒来排尿，但在針灸治疗后时常能使遺尿症痊愈或显著好轉的机轉，是应用金属等制成的針刺激分布于关元或三阴交等穴位的神經后，能够在大脑皮質建立或加强管制排尿动作的警戒点(或称值班点)，加强了大脑皮質管制排尿动作的机能，于睡眠中当膀胱脹滿的时候，能够感到尿意即刻自动醒来排尿。通过針灸治疗儿童夜間遺

尿症的實踐，使我更加深刻地認識到針灸所以能夠治病是因為針灸能夠加強大腦皮質的調節與管制機能。

應用金屬等制成的針刺激神經時，能夠在大腦皮質產生一個新的興奮灶，使原已存在於大腦皮質的病理興奮灶受到抑制，因而在臨床上看不到針刺前臂的列缺或手上的合谷穴可以治療頭痛。

針刺人中穴能迅速治好休克的原則是這樣解釋的，應用金屬等制成的針給予分布於人中穴的神經以機械性刺激時，可以在大腦皮質引起興奮過程，而能解除病理性超限抑制，而能迅速治好休克。

總 結

針灸療法是祖國寶貴醫學遺產之一，實踐證明針灸確能治病。根據經絡學說可以解釋針灸為什麼能治病。針灸刺激經絡後可以起到疏通經絡，宣導氣血，補虛瀉實之作用，故能治病。通過應用針灸治病的實踐，初步体会到針灸治病的原理，不但可以根據經絡學說解釋，而且可以應用維金斯基機能活動性學說與問生態學說、巴甫洛夫高級神經活動學說及貝柯夫大腦皮質與內臟相關學說加以解釋。

應用金屬等制成的針或艾絨等燃着後所產生的溫熱給予神經以弱刺激時，可以產生興奮作用；應用針灸給予神經以強刺激時，可以產生抑制作用，而能达到“虛則補之，實則瀉之，”的目的。

應用金屬等制成的針或艾絨等燃着後所產生的溫熱刺激神經後，能夠提高組織的機能活動性，發揮抗問生的作用，使組織由陰性營養反應轉變為陽性營養反應，能夠加強機體的反應性，能夠加強大腦皮質的調節與管制機能，和調整大腦皮

质的机能活动，使大脑皮质兴奋与抑制兩基本神經过程的平衡得以恢复，使高級神經活动的障碍得以恢复，因而能治好很多种疾病。

針灸疗法是科学的，針灸治病的原理是值得深入研究的。

警世救人功德無量